

UNITÉ PÉDAGOGIQUE

FICHES D'APPRENTISSAGE EN TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

*" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. "*



L1
TC

**SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIERE**

2025- 2026



I- GENERALITES

Les techniques de soins infirmiers constituent le cœur opérationnel de la profession. Elles ne se résument pas à une simple exécution mécanique, mais s'inscrivent dans une démarche clinique rigoureuse visant à maintenir, restaurer ou promouvoir la santé. Voici une synthèse des fondamentaux qui régissent ces pratiques :

1. Le cadre légal et déontologique

Toute technique repose sur un **décret de compétences**. L'infirmier agit soit sur prescription médicale (rôle délégué), soit dans le cadre de son **rôle propre** (autonomie pour les soins d'hygiène, de confort et de prévention). La responsabilité de l'acte est engagée dès sa réalisation.

2. Les principes transversaux de sécurité

Avant tout geste, quatre piliers sont systématiquement respectés :

- **L'Hygiène** : Lavage des mains (solution hydro-alcoolique), port de gants et respect de l'asepsie pour prévenir les infections associées aux soins (IAS).
- **L'Identité-vigilance** : Vérification stricte de l'identité du patient pour éviter toute erreur de soin.
- **L'ergonomie** : Utilisation de techniques de manutention pour protéger le dos du soignant et assurer la sécurité du patient.
- **L'économie** : Utilisation rationnelle du matériel sans compromettre la qualité.

3. La relation de soin

Une technique n'est jamais "pure" ; elle est indissociable de la communication :

- **Information et consentement** : Expliquer le soin au patient pour diminuer l'anxiété.
- **Installation** : Garantir le confort et respecter la pudeur (intimité).
- **Observation** : Pendant le soin, l'infirmier évalue l'état clinique (douleur, signes paramètres vitaux).

4. La démarche qualité (La Règle des 5B)

Principalement pour l'administration de thérapeutiques, on applique la règle d'or :

- 1. Bon patient
- 2. Bon médicament (ou bon soin)
- 3. Bonne dose
- 4. Bonne voie
- 5. Bon moment

5. La traçabilité

Le soin n'est considéré comme "terminé" qu'une fois **transcrit** dans le dossier de soins. Cette transmission (écrite et orale) assure la continuité des soins et la protection juridique du professionnel.

Souhaitez-vous que j'approfondisse une technique spécifique, comme la pose d'une perfusion ou la réfection d'un pansement stérile ?

1. Conduite des soins à l'examen
2. Fiche n°1 : Fiche Technique de la grille d'évaluation pour habileté technique.

II- PARAMÈTRES VITAUX

1. Fiche n°2 : Prise de la température (T°)
2. Fiche n°3 : Prise du pouls (π)
3. Fiche n°4 : Prise de la Tension Artérielle (TA)
4. Fiche n°5 : Mesure du poids (Pds) et de la taille (T), calcul d'Indice de Masse Corporelle (L'IMC)
5. Fiche n°6 : Mesure de la Fréquence respiratoire
6. Fiche n°7 : Recueil des urines – Mesure de la Diurèse
7. Fiche n°8 : Remplissage de la feuille de température (T°)

III-SOINS D'HYGIENE ET DE CONFORT

1. Fiche n°9 : Toilette générale du malade
2. Fiche n°10 : Soins des cavités naturelles
3. Fiche n°11 : Réfection de lit non occupé
4. Fiche n°12 : Réfection de lit occupé
5. Fiche n°13 : Installation et diverses positions du malade
6. Fiche n°14 : Prévention des escarres
7. Fiche n°15 : Lavage simple des mains
8. Fiche n°16 : Lavage chirurgical des mains
9. Fiche n°17 : Port et Retrait des gants

IV-SOINS MÉDICAUX

1. Fiche n°18 : Injection intradermique
2. Fiche n°19 : Injection Sous-cutanée (SC)
3. Fiche n°20 : Injection Intramusculaire (IM)
4. Fiche n°21 : Injection Intraveineuse (IV)
5. Fiche n°22 : Perfusion intraveineuse simple
6. Fiche n°23 : Transfusion sanguine
7. Fiche n°24 : Prélèvement sanguin
8. Fiche n°25 : Prélèvement de selles
9. Fiche n°26 : prélèvement des crachats

V- SOINS CHIRURGICAUX ET DE CONTACT

1. Fiche n°27 : Pansement
2. Fiche n°28 : Bandage
3. Fiche n°29 : Réalisation d'une écharpe
4. Fiche n°30 : Pose d'une gouttière
5. Fiche n°31 : Pose d'une attelle
6. Fiche n°32 : Lavage de vessie
7. Fiche n°33 : Vessie de glace
8. Fiche n°34 : Bouillotte

I- GENERALITES**CONDUITE DES SOINS A L'EXAMEN****AVANT LA PRATIQUE**

- Saluer les enseignants
- Tirer un numéro d'ordre
- Tirer le soin selon le numéro d'ordre
- Lire à haute voix le soin tiré par le candidat

PENDANT LA PRATIQUE

- Aller au lit du client
- Saluer le client et ses parents
- Se présenter au client et à ses parents
- Informer le client et ses parents du soin à faire
- Prendre connaissance du dossier médical et du dossier infirmier du client
- Se laver les mains à l'eau et au savon
- Réunir le matériel nécessaire au soin
- Informer le client et ses parents de l'imminence du soin
- Faire sortir poliment les parents si nécessaire
- Fermer les portes et fenêtres si nécessaire
- Préparer le soin
- Appliquer le soin selon la technique enseignée
- Réinstaller le client
- Noter le soin sur la feuille de température
- Faire la CCC au malade et ou au parent en rapport avec le soin
- Remercier le client et/ou ses parents

APRES LA PRATIQUE

- Présenter le soin selon le modèle enseigné
- Répondre aux questions posées par les enseignants
- Remercier les enseignants et prendre congés d'eux

MATERIEL INDISPENSABLE POUR REALISER UN PANSEMENT

Le matériel de pansement est composé comme suit :

4-1 Matériel spécifique

- Boîtes à instruments (pince à servir, pince à disséquer avec et sans griffe, pince de Kocher, PEAN, MANDRIN, sonde cannelée, lame de bistouri, paires de ciseaux..) stériles
- Boîtes ou tambours de compresses stériles
- flacons d'antiseptiques (Bétadine jaune, Bétadine rouge, alcool, dakin, éther, Mercryl, lauryl...)
- matériel de contention (bande de crêpe, Velpeau ou gaze et du sparadrap)
- coton hydrophile, coton cardé
- Médicaments prescrits (pommade, poudre, ATB)

4-2 Matériel courant

- Chariot
- Deux plateaux
- Un haricot
- Gants stériles ou propres
- du Savon, serviette
- Une poubelle
- Une alèze

Le chariot à pansement

Le chariot à pansement est un engin métallique à quatre roues comportant 3 niveaux maximum destiné à transporter le matériel de pansement jusqu'au lit du malade.

On dispose le matériel stérile sur l'étage supérieur, le matériel propre sur l'étage moyen et tout le matériel septique (haricot et poubelle) sur l'étage inférieur.

S'il s'agit d'un chariot à deux étages, disposer le matériel aseptique sur l'étage supérieur et le matériel septique sur l'étage inférieur.

FICHE N°1 : GRILLE D'EVALUATION POUR HABILETE TECHNIQUE.

Nom et prénoms de l'étudiant :

Matricule de l'étudiant :

Nom et prénoms de l'observateur :

Date :

Note : / 20

Critères d'évaluation	Pondération	Accompli	Partiellement accompli	Non accompli	Score
I-IDENTIFICATION DU CLIENT	3				
Salue le client	0.5				
Se présente au client	0.5				
Explique le soin au client	1				
Évalue l'état du client	1				
II-REUNION ET PREPARATION DU MATERIEL	4				
Se lave les mains	1				
Identifie le matériel nécessaire au soin	1				
Nettoie le plan du travail (chariot)	1				
Dispose le matériel dans l'ordre d'utilisation	1				
III-TECHNIQUE DE SOIN	7				
Assure la pudeur du client	1				
Exécute le soin en respectant les étapes du processus	6				
IV-IEC/CCSC	3				
Donne un enseignement conformément au soin	2.5				
Prends congé du client sur des paroles encourageantes	0.5				

V- RECONDITIONNEMENT DU MATERIEL	2			
Nettoie le matériel	1			
Range le matériel	0,5			
Se lave les mains	0,5			
VI- COMMUNICATION DES SOINS	1			
Note le soin	1			
TOTAL	20	20	10	00

DIRECTIVES :

- Accomplie : 20 points
- Partiellement accomplie : 10 points
- Non accomplie : 00 point

NB : chaque tâche accomplie obtient la totalité des points alloués, celle partiellement accomplie obtient la moitié et celle non accomplie obtient la note zéro.

**I- PARAMÈTRES VITAUX****FICHE N°2 : PRISE DE LA TEMPERATURE (T°)**

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
Enfiler des gants propres	
Prendre un Chariot de soins ou plateau propre	Facilite l'organisation rationnelle du matériel et limite les contaminations
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Préparer la feuille de température ou de surveillance	Support légal et traçabilité des constantes
Prévoir un Bic bleu	Inscription correcte et normalisée des résultats
Vérifier le thermomètre	Garantir la fiabilité de la mesure
Préparer coton ou compresses	Nettoyage et désinfection du thermomètre
Préparer la solution antiseptique	Prévention des infections
Prévoir un haricot / réniforme	Réception et transport sécurisé du matériel utilisé

III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE**1- Température rectale**

Informar le malade de l'imminence du soin	Obtention de l'adhésion du patient
Vérifier et secouer le thermomètre	Assurer la descente du mercure
Désinfecter le thermomètre	Prévenir les infections
Installer en position latérale jambes fléchies	Facilite l'accès et assure la sécurité
Introduire doucement le thermomètre	Mesure précise de la température centrale
Maintenir 3 à 5 minutes	Fiabilité du résultat
Retirer et lire le résultat	Interprétation immédiate
Inscrire le résultat sur la feuille de température	Traçabilité médico-légale
Réinstaller confortablement le client	Respect du bien-être
Nettoyer et ranger le matériel	Maintien de l'hygiène
Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission

2- Température buccale

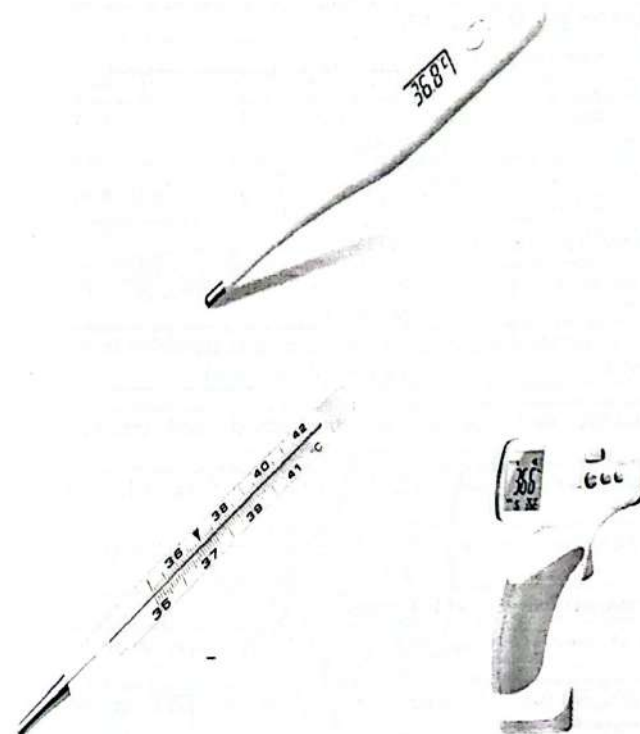
Mettre le client au repos	Fiabilité de la mesure
Désinfecter le thermomètre	Sécurité
Placer le réservoir sous la langue	Mesure correcte
Demander de fermer la bouche sans mordre	Évite le bris du thermomètre
Maintenir 10 minutes	Résultat fiable
Lire et noter le résultat	Traçabilité
Réinstaller et remercier le client	Relation soignant-soigné
Nettoyer matériel et hygiène des mains	Prévention infection

3- Température axillaire

Installer au repos	Éviter variations
Sécher l'aisselle	Éviter fausse lecture
Placer le réservoir dans le creux axillaire	Mesure correcte
Maintenir bras contre le corps 5 min	Contact optimal
Lire le résultat	Interprétation
Ajouter +0,5°C au résultat	Correction température externe
Noter sur feuille de température	Traçabilité conforme
Réinstaller le client	Confort
Nettoyer matériel et hygiène des mains	Prévention infection

IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)

Expliquer l'importance de la surveillance thermique	Détection de toute anomalie et suivi de l'évolution de l'état du patient.
Encourager le signalement de frissons/douleur	Participation active du client
Sensibiliser à l'observance thérapeutique	Amélioration du pronostic
Informar la famille si nécessaire	Continuité des soins



FICHE N°3 : MESURE DU POULS RADIAL

Tâches	Contenu/Justifications
I. PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueil du patient et vérification de son identité.	Prévention des erreurs d'identification sécurisation du soin.
Information du patient sur le but et le déroulement du soin.	Réduction de l'anxiété et obtention de coopération.
Installation du patient au repos (5 à 10 minutes).	Neutralisation des facteurs de stress ou d'effort (fiabilité de la mesure).
Demande de consentement oral.	Respect de l'autonomie et de l'intégrité physique du patient.
II. PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Vérification du fonctionnement de la montre à trotteuse.	Précision du décompte temporel.
Préparation du support de notation (dossier de soins).	Immédiateté de la traçabilité et évitement d'oublis.
Mise à disposition d'une solution hydro-alcoolique (SHA).	Application des précautions standards d'hygiène.
III. TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique.	Rupture de la chaîne de transmission des micro-organismes.
Positionnement de la pulpe des 3 doigts moyens sur l'artère.	Optimisation de la sensibilité tactile (exclusion du pouls du soignant).
Compression modérée de la gouttière radiale.	Perception nette de l'onde sans occlusion de la lumière artérielle.
Décompte des pulsations sur 60 secondes.	Détection fine du rythme, de l'amplitude et de la symétrie.
Évaluation qualitative (rythme et amplitude).	Identification des anomalies (arythmie, pouls filant ou bondissant).
IV. CCSC (Communication pour le Changement)	
Restitution de la valeur obtenue au patient.	Éducation thérapeutique et renforcement de l'auto-surveillance.
Explication de l'impact des facteurs de risque (tabac, stress).	Promotion de la santé et sensibilisation cardiovasculaire.
Échange sur les ressentis ou les doutes du patient.	Établissement d'une relation de confiance (alliance thérapeutique).
Conseil sur le suivi régulier auprès du médecin.	Continuité des soins et prévention secondaire.



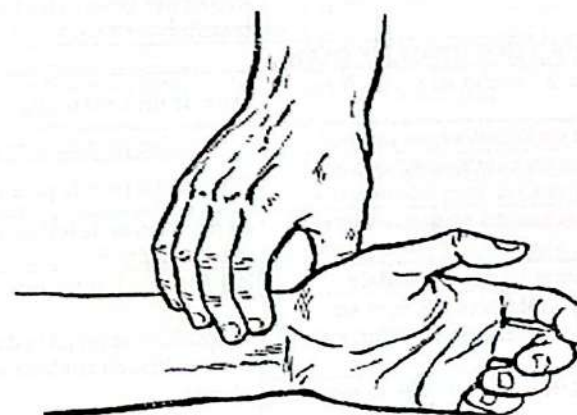
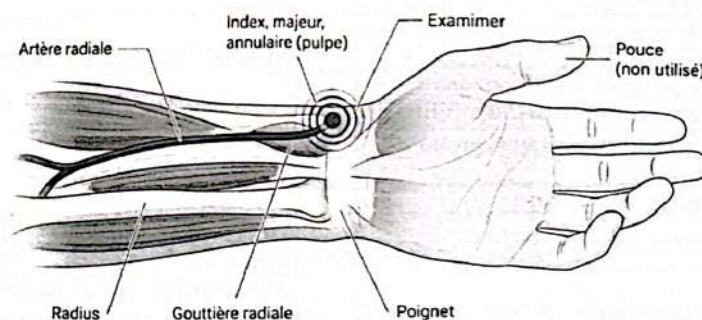
SYNTHÈSE DES PARAMÈTRES CLINIQUES :

- **Fréquence** : 60 - 100 bpm (Norme adulte).
- **Rythme** : Régularité de l'intervalle entre deux battements.
- **Amplitude** : Force de l'onde pulsatile perçue.

MATÉRIEL POUR LA PRISE DU POULS

- Une montre avec trotteuse
- Un stylo rouge
- Une feuille de température ou de surveillance ou le carnet de suivi du malade

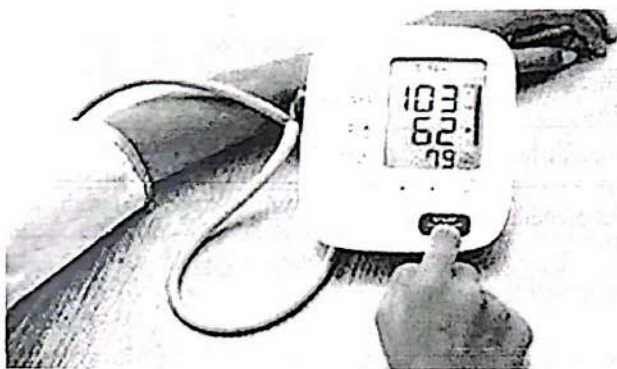
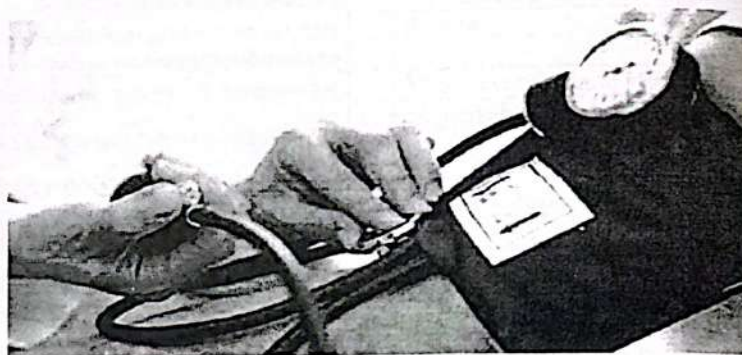
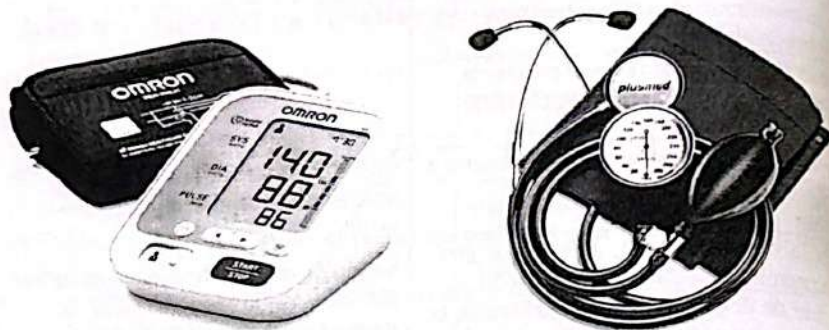
Technique correcte de palpation du pouls radial



FICHE N°4 : PRISE DE LA TENSION ARTERIELLE

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, L'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de son diagnostic médical
Se présenter à lui	
Expliquer le soin au patient	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Le rassurer de son innocuité	
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en décubitus dorsal ou assis, au repos	Mise en condition favorable pour le soin
Le mettre au repos depuis au moins 10mn	
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (tensiomètre, stéthoscope, stylo rouge, support de notification)
Oter les gants	Retrait des gants après avoir réuni le matériel
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Dénuder le bras en retirant tout vêtement gênant	Disposition pour la pose du brassard
Tenir le bras au niveau du plan du cœur si le client est assis	Application de la technique de la prise de tension artérielle
Rechercher au palper l'artère brachiale	Repérage de l'artère brachiale
Placer le brassard sur le bras à 2,5cm au-dessus du siège de la pulsation de l'artère brachiale	Disposition appropriée du brassard, du manomètre, du tambour sur le bras du client
Placer le manomètre à la verticale au niveau des yeux	

Placer la membrane du stéthoscope sur l'artère brachiale	
Fermer la soupape de la poire et gonfler le brassard jusqu'à 30mmHg au-dessus de la normale	
Ouvrir lentement la soupape pour permettre à l'aiguille ou au mercure de descendre lentement	Lente ouverture de la soupape pour une meilleure perception du battement cardiaque
Repérer la valeur indiquée sur le manomètre lors du premier bruit clairement entendu	Repérage ou identification de la valeur indiquée sur le manomètre lors du premier et du dernier bruit clairement entendu
Continuer de dégonfler le brassard et noter la valeur du manomètre qui correspond au silence	
Dégonfler complètement le brassard	Retrait complet du tensiomètre
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer la pression	Information du résultat obtenu au patient
Consigner le soin sur la feuille de température ou de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client et à sa famille, l'intérêt de contrôler régulièrement la tension	Disposition pour dépistage et suivi d'une éventuelle hausse ou baisse des chiffres tensionnels
Conseiller au patient des exercices physiques réguliers adaptés	Prescription et conseil pour prévenir l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires
Conseiller aux patients des mesures d'hygiène alimentaires	
Faire un feed-back au patient	Evaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans cette relation soignant-soigné



FICHE N°5 : MESURE DU POIDS (PDS) ET DE LA TAILLE (T), CALCUL

TÂCHES	JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de l'identité et conformité à la prescription
Se présenter au patient	Instaurer un climat de confiance
Expliquer le soin au patient	Favoriser la coopération et l'adhésion
Rassurer sur l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant	Éviter toute interruption du soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
Enfiler des gants propres (si nécessaire)	
Réunir le matériel nécessaire (toise murale ou stadiomètre)	Éviter les interruptions
Vérifier l'état de la toise (graduations visibles, position verticale)	Exactitude de la mesure
Préparer la feuille ou registre pour noter la taille	Assurer la traçabilité
Prévoir un stylo	Inscription lisible et codifiée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Informer le malade de l'imminence du soin	Adhésion et respect des droits du patient
Installer le patient debout, dos contre la toise	Assurer une mesure correcte
Vérifier que les talons, fesses, épaules et tête touchent le support	Standardisation de la posture
Placer la tête dans le plan de Francfort (regard horizontal)	Précision anatomique de la mesure
Abaissier la règlette au sommet du crâne	Exactitude de la donnée
Lire la taille à hauteur des yeux	Fiabilité de la lecture
Noter immédiatement la taille sur la feuille	Traçabilité et suivi clinique
Répéter la mesure si doute	Vérification de la cohérence
Aider le patient à se rhabiller si nécessaire	Respect et confort
Laver les mains après le soin	Rupture de la chaîne de transmission
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'importance de la mesure de la taille	Calcul de l'IMC et évaluation nutritionnelle
Inform sur la surveillance de la croissance (chez l'enfant/adolescent)	Détection précoce des anomalies
Inform la famille si nécessaire	Continuité et suivi des soins

FICHE TECHNIQUE D'APPRENTISSAGE : LE TOISAGE (MESURE DE LA TAILLE)

Public cible : Étudiants en Soins Infirmiers (Niveau Licence)

Objectif pédagogique : Réaliser la mesure de la stature avec précision pour l'évaluation anthropométrique et clinique.

Tableau de Procédure

TÂCHES	JUSTIFICATIONS
I. PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Saluer le patient et décliner son identité professionnelle.	Instauration d'une relation de confiance et respect de l'éthique.
Décliner les objectifs du soin (calcul de l'IMC, posologie médicamenteuse, suivi de croissance).	Obtention du consentement libre et éclairé du bénéficiaire.
Expliquer l'importance de la posture rigoureuse et du déchaussage.	Optimisation de l'observance et prévention des biais de mesure.
II. PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Vérifier l'étalonnage et la verticalité de la toise murale ou mobile.	Garantie de la fiabilité et de la reproductibilité de la donnée.
Désinfecter le socle et la réglette (solution détergente-désinfectante).	Interruption de la chaîne de transmission croisée (asepsie).
Organiser le support de recueil (dossier de soins, carnet de santé).	Efficacité de l'organisation et immédiateté de la saisie.
III. TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Faire retirer les chaussures et tout accessoire capillaire (chignon, chapeau).	Annulation des surcharges de hauteur artificielle.
Aligner les talons (joints), les fesses, les omoplates et l'occiput contre le plan vertical.	Alignement anatomique axial et rectitude du rachis.
Ajuster la tête selon le "Plan de Frankfurt" (bord inférieur de l'orbite et tragus à l'horizontale).	Standardisation de la posture céphalique et précision du vertex.
Abaissier la réglette tangentiellement au vertex après une inspiration profonde.	Extension maximale de la colonne et exactitude du relevé.

Effectuer la lecture à hauteur des yeux de l'examineur.	Élimination de l'erreur de parallaxe.
IV. COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Restituer le résultat au patient en l'insérant dans les normes de référence (OMS).	Éducation à l'auto-surveillance et valorisation de la santé.
Discuter du lien entre la stature, le poids et les risques métaboliques.	Sensibilisation aux déterminants de santé et prévention de l'obésité/dénutrition.
Encourager la régularité du suivi biométrique au sein des structures sanitaires.	Renforcement du recours aux soins et promotion de la santé communautaire.

SYNTHESE CLINIQUE (NIVEAU Licence)

- **Vigilance** : Chez le sujet âgé, la diminution de la taille peut révéler un tassement vertébral (ostéoporose).
- **Transmissions** : Inscription de la valeur en centimètres (cm) ou mètres (m), horodatage, et signature de l'étudiant/infirmier.
- **Maintenance** : Signalement de tout dysfonctionnement du matériel pour recalibrage.

FICHE TECHNIQUE D'APPRENTISSAGE : LE TOISAGE (MESURE DE LA TAILLE)

Public cible : Étudiants en Soins Infirmiers (Niveau Licence)

Objectif pédagogique : Réaliser la mesure de la stature avec précision pour l'évaluation anthropométrique et clinique.

Tableau de Procédure

TÂCHES	JUSTIFICATIONS
I. PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Saluer le patient et décliner son identité professionnelle.	Instauration d'une relation de confiance et respect de l'éthique.
Décliner les objectifs du soin (calcul de l'IMC, posologie médicamenteuse, suivi de croissance).	Obtention du consentement libre et éclairé du bénéficiaire.
Expliquer l'importance de la posture rigoureuse et du déchaussage.	Optimisation de l'observance et prévention des biais de mesure.
II. PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Vérifier l'étalonnage et la verticalité de la toise murale ou mobile.	Garantie de la fiabilité et de la reproductibilité de la donnée.
Désinfecter le socle et la règlette (solution détergente-désinfectante).	Interruption de la chaîne de transmission croisée (asepsie).
Organiser le support de recueil (dossier de soins, carnet de santé).	Efficience de l'organisation et immédiateté de la saisie.
III. TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Faire retirer les chaussures et tout accessoire capillaire (chignon, chapeau).	Annulation des surcharges de hauteur artificielle.
Aligner les talons (joints), les fesses, les omoplates et l'occiput contre le plan vertical.	Alignement anatomique axial et rectitude du rachis.
Ajuster la tête selon le "Plan de Frankfurt" (bord inférieur de l'orbite et tragus à l'horizontale).	Standardisation de la posture céphalique et précision du vertex.
Abaissier la règlette tangentiellement au vertex après une inspiration profonde.	Extension maximale de la colonne et exactitude du relevé.

Effectuer la lecture à hauteur des yeux de l'examineur.

Élimination de l'erreur de para...

IV. COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)

Restituer le résultat au patient en l'insérant dans les normes de référence (OMS).

Éducation à l'auto-surveillance et valorisation de la santé.

Discuter du lien entre la stature, le poids et les risques métaboliques.

Sensibilisation aux déterminants de santé et prévention de l'obésité/dénutrition.

Encourager la régularité du suivi biométrique au sein des structures sanitaires.

Renforcement du recours aux soins et promotion de la santé communautaire.

SYNTHÈSE CLINIQUE (NIVEAU Licence)

- **Vigilance** : Chez le sujet âgé, la diminution de la taille peut révéler un tassement vertébral (ostéoporose).
- **Transmissions** : Inscription de la valeur en centimètres (cm) ou mètres (m), horodatage, et signature de l'étudiant/infirmier.
- **Maintenance** : Signalement de tout dysfonctionnement du matériel pour recalibrage.

FICHE N°6 : MESURE DE LA FREQUENCE RESPIRATOIRE

Tâches (Actions de l'infirmier)	Justifications (Substantifs)
I. PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Établir un contact visuel et saluer le patient sans annoncer la mesure précise.	Préservation de la spontanéité du rythme et évitement du stress lié à l'observation.
Expliquer que l'on procède à une surveillance globale des paramètres vitaux.	Obtention du consentement et instauration d'un climat de confiance.
S'assurer que le patient est au repos strict depuis 15 min.	Standardisation de la mesure et élimination des facteurs de biais.
II. PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se munir d'une montre avec trotteuse ou d'un chronomètre.	Précision du décompte temporel.
Préparer le support de transmission et un stylo.	Traçabilité immédiate des données recueillies.
Utiliser une solution hydro-alcoolique (SHA).	Respect de l'hygiène des mains et rupture de chaîne de transmission.
III. TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Simuler la prise du pouls radial en maintenant la main sur le poignet.	Diversion de l'attention pour garantir une respiration réflexe.
Observer les mouvements thoraciques ou abdominaux sur 60 secondes.	Fiabilité du résultat et détection des arythmies respiratoires.
Évaluer l'amplitude, la régularité et les bruits adventices.	Sémiologie clinique et dépistage de signes de détresse.
IV. COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMORTEMENTAL	
Informier le patient sur ses résultats par rapport aux normes.	Éducation à la santé et autonomisation du patient.
Sensibiliser sur les facteurs influençant la respiration (tabac, posture).	Promotion de saines habitudes de vie et prévention des risques.
Encourager l'expression des ressentis (douleur, gêne) par le patient.	Renforcement de l'alliance thérapeutique et valorisation du vécu.

FICHE N°7 : RECUEIL DES URINES – MESURE DE LA DIURESE

Tâches	Justifications
I - PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Contenant gradué : Préparation d'un bocal à urines propre et d'une éprouvette de mesure.	Précision du volume et hygiène du dispositif.
Étiquetage : Identification du patient, de la date et de l'heure de début sur le bocal.	Sécurité identitovigilance et prévention des erreurs de dossier.
Protections : Port de gants à usage unique (et tablier si nécessaire).	Protection contre le risque biologique et les projections.
Hygiène des mains : Utilisation de savon doux ou de solution hydro-alcoolique.	Prévention des infections croisées et antiseptie.
II - COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT	
Éducation thérapeutique : Expliquer l'intérêt clinique du recueil pour le diagnostic.	Adhésion du patient au projet de soins et motivation.
Consignes d'autonomie : Rappeler de ne pas jeter les urines et d'utiliser le bocal dédié.	Responsabilisation et limitation des risques de perte d'échantillon.
Vérification de la compréhension : Demander au patient de reformuler la procédure (méthode du "Teach-back").	Validation de l'assimilation et sécurisation du processus.
III - TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Initialisation : Vidange de la vessie à l'heure H (ex: 8h) ; élimination de ces premières urines.	Détermination exacte du point de départ du cycle de 24h.
Collecte : Recueil de la totalité des mictions dans le contenant dédié pendant 24h.	Exhaustivité de l'échantillon pour l'analyse quantitative.
Clôture : Vidange finale de la vessie à J+1 à l'heure H (ex: 8h) dans le bocal.	Exactitude du temps de production rénale sur le cycle complet.
Lecture : Lecture du volume sur l'éprouvette (surface plane) à hauteur des yeux.	Rigueur de la mesure et élimination de l'erreur de parallaxe.
Transmissions : Inscription du volume, de la couleur et de l'aspect dans le dossier de soins.	Traçabilité clinique et surveillance de la fonction rénale.
Entretien : Vidage, rinçage et décontamination du matériel réutilisable.	Respect des protocoles d'hygiène et de sécurité environnementale.

FICHE N°8 : TENUE DE LA FEUILLE DE TEMPERATURE (T°)

Tâches	Contenus / justifications
I- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains	Prévention des infections et respect des règles d'asepsie
Rassembler le matériel (stylo bleu, rouge, vert, jaune)	Inscription codifiée et normalisée des rubriques
Prendre la feuille de température	Support officiel de traçabilité des soins
II- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Noter le régime prescrit	Adaptation nutritionnelle à l'état clinique
Noter en rouge la date d'entrée	Repérage chronologique du début d'hospitalisation
Reporter la date en bleu et compléter les suivantes	Organisation temporelle du suivi
Recopier le traitement selon la hiérarchie des voies	Clarté, cohérence et sécurité thérapeutique
Inscrire le sang en rouge si transfusion	Identification rapide et sécurité transfusionnelle
Inscrire les solutés selon la prescription	Traçabilité des perfusions administrées
Noter les injections IV en rouge	Identification des injections veineuses et renforcement de la vigilance.
Noter les injections IM, SC, ID	Traçabilité des voies parentérales
Noter les voies orales	Suivi et contrôle des traitements per os
Noter les voies rectales	Surveillance des administrations spécifiques
Noter les voies locales (cutanée, muqueuse...)	Suivi global des prescriptions
Première partie : Partie administrative (Identification)	
Noter le nom de l'hôpital, chambre et lit	Identification précise du lieu d'hospitalisation
Noter nom, prénoms, domicile, âge, sexe, région	Identification complète et sécurisée du patient
Noter le diagnostic (code affection)	Orientation clinique et continuité des soins
Noter le régime prescrit	Adaptation nutritionnelle à l'état clinique

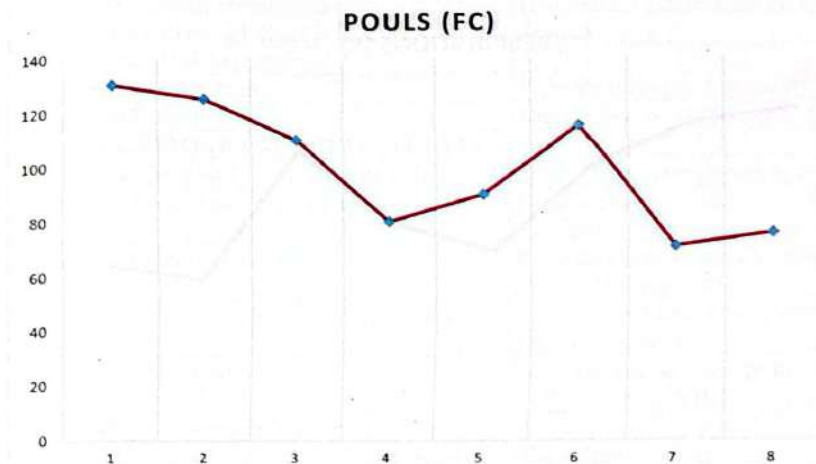
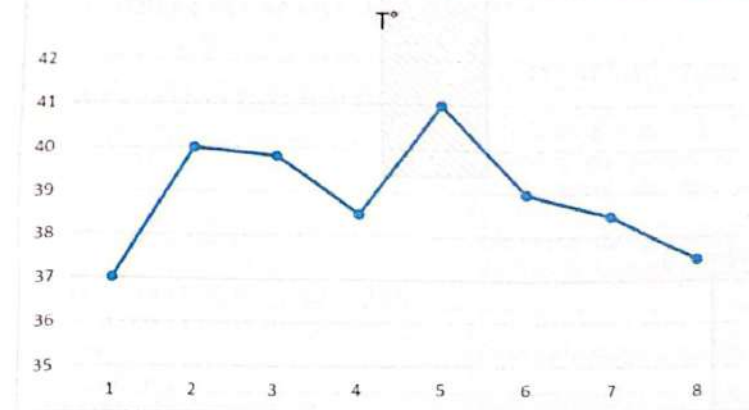
Deuxième partie : Partie traitement	
Noter en rouge la date d'entrée	Repérage chronologique du début d'hospitalisation
Reporter la date en bleu et compléter les suivantes	Organisation temporelle du suivi
Recopier le traitement selon la hiérarchie des voies	Clarté, cohérence et sécurité thérapeutique
Inscrire le sang en rouge si transfusion	Identification rapide et sécurité transfusionnelle
Inscrire les solutés selon la prescription	Traçabilité des perfusions administrées
Noter les injections IV en rouge	Distinction des voies veineuses et vigilance accrue
Noter les injections IM, SC, ID	Traçabilité des voies parentérales
Noter les voies orales	Suivi des traitements per os
Noter les voies rectales	Surveillance des administrations spécifiques
Noter les voies locales (cutanée, muqueuse...)	Suivi global des prescriptions
Marquer le soin effectué (✓, X, O...)	Validation de l'acte réalisé
Dessiner une flèche rouge à la date d'opération	Signalement d'un événement chirurgical
Marquer une double flèche pour traitement arrêté	Indication claire d'arrêt thérapeutique
Troisième partie : Partie bilan	
Noter les examens biologiques/radiologiques demandés	Suivi des prescriptions médicales
Reporter les résultats si nécessaire	Surveillance évolutive et aide à la décision médicale
Quatrième partie : Partie des paramètres ou constantes	
Construire les graphiques après prise des constantes	Visualisation synthétique de l'évolution clinique
Courbe bleue pour la température (échelle 0,2°C)	Suivi précis des variations thermiques
Courbe rouge pour le pouls (échelle 3 pulsations)	Surveillance de l'état hémodynamique
Courbe verte pour la respiration (échelle 1 mouvement)	Surveillance de la fonction respiratoire

Histogramme rouge hachuré pour la TA (échelle 1)	Contrôle structuré de la pression artérielle
Histogramme jaune pour les urines (échelle 0,1 L)	Surveillance de la diurèse et de l'équilibre hydrique
Ranger la feuille de température dans le dossier infirmier	Assure la traçabilité médico-légale et la continuité des soins
Cinquième partie : Partie surveillance	
Noter le poids quotidien si nécessaire	Surveillance nutritionnelle et hydrique
Noter les selles (aspect et fréquence)	Évaluation digestive
Noter les vomissements (aspect et quantité)	Surveillance des pertes
Noter les pansements	Suivi des plaies et écoulements
Noter le poids quotidien si nécessaire	Surveillance nutritionnelle et hydrique

IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)

Expliquer l'importance de la surveillance des constantes	Participation active du patient
Conseiller de signaler toute fièvre, douleur ou malaise	Détection précoce des complications
Sensibiliser à l'importance du respect du traitement	Amélioration du pronostic du patient
Encourager la collaboration du patient	Renforcement de l'autonomie
Vérifier la cohérence des données inscrites	Présentation des erreurs médico-légales
Signer ou parapher la feuille de température	Responsabilité professionnelle

EXEMPLES DE REPRESENTATIONS DES PARAMETRES VITAUX SUR LA FT°



II- SOINS D'HYGIENE ET DE CONFORT

FICHE N°9 : TOILETTE GENERALE DU MALADE

TACHES	CONTENUS/JUSTIFICATION
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
1. Aller vers le patient	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de son diagnostic médical
2. Présenter à lui	
3. Expliquer le soin au malade	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
1. Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
2. Assécher les mains	
3. Enfiler les gants propres	
4. Prendre un chariot à deux niveaux	Disposition pour assurer la sécurité du soin
5- Nettoyer le chariot	Prise de mesures d'asepsie
6-reunir le matériel	Mise à disposition du matériel
7-Disposer le matériel aseptique à l'étage supérieur et le matériel sceptique à l'étage inférieur	Disposition rationnelle du matériel de soin
8-Oter les gants selon la technique	Prise de mesures d'asepsie
Se laver à nouveau les mains	
Aller au lit du Patient	Disposition pour réaliser le soin
III- TECHNIQUE D'INTERPREMENT DITE	
1. Informer le patient de l'importance du soin	Disposition pour démarrer le soin
2. Faire sortir les visiteurs	Disposition pour préserver l'intimité du patient
3. Fermer les portes et les fenêtres	Prise de mesures pour le respect de l'intimité du patient
4. Mettre le patient dans une position confortable	Mise en posture convenable pour favoriser le soin
5. Appeler à l'aide si besoin	Sollicitation d'aide pour assurer l'efficacité et l'efficacité du soin
6. Couvrir le patient avec une couverture imperméable sous le malade	Disposition pour protéger le matelas et la literie, Prise de mesures d'asepsie
7. Nettoyer les mains, les passer à l'alcool ou porter des gants stériles	
IV- DEROULEMENT : Toilette du visage, du cou et des oreilles	
1. Dévêtir le malade progressivement,	Disposition pour avoir accès aux sites de soin

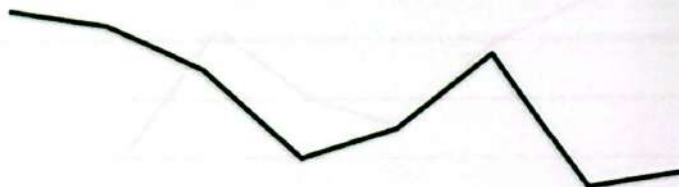
La Tension artérielle (TA)



La Diurèse (U)



RESPIRATIONS (R)



II- SOINS D'HYGIENE ET DE CONFORT

FICHE N°9 : TOILETTE GENERALE DU MALADE

TACHES	CONTENUS/JUSTIFICATION
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
1. Identifier le patient	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de son diagnostic médical
2. Se présenter à lui	
3. Expliquer le soin au malade	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
1. Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
2. Assécher les mains	
3. Enfiler les gants propres	
4. Prendre un chariot à deux niveaux	Disposition pour assurer la sécurité du soin
5- Nettoyer le chariot	Prise de mesures d'asepsie
6-reunir le matériel	Mise à disposition du matériel
7-Disposer le matériel aseptique à l'étage supérieur et le matériel sceptique à l'étage inférieur	Disposition rationnelle du matériel de soin
8-Oter les gants selon la technique	Prise de mesures d'asepsie
Se laver à nouveau les mains	
Aller au lit du Patient	Disposition pour réaliser le soin
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
1. Informer le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer le soin
2. Faire sortir les parents et les visiteurs	Disposition pour préserver l'intimité du patient
3. Fermer portes et fenêtres	Prise de mesures pour le respect de l'intimité du patient
4. Installer le malade dans une position confortable	Mise en posture convenable pour favoriser le soin
5. Se faire aider au besoin	Sollicitation d'aide pour assurer l'efficience et l'efficacité du soin
6. Placer l'alèze imperméable sous le malade	Disposition pour protéger le matelas et la literie, Prise de mesures d'asepsie
7. Se laver les mains, les passer à l'alcool ou porter des gants stériles	
Première partie : Toilette du visage, du cou et des oreilles	
8. Dêvêtir le malade progressivement,	Disposition pour avoir accès aux sites de soin

9. Laver les yeux sans savon avec un gant de toilette en allant de l'angle interne vers l'angle externe si l'œil n'est pas chassieux.	Respect de la technique nettoyage des yeux (élimination des sécrétions et impuretés, prévention des infections oculaires.)
10. Savonner le visage, le cou, les oreilles.	Élimination des impuretés transpirations des zones concernées
11. Rincer, essuyer, en insistant sur les plis..	
12. Appliquer la vaseline ou du beurre de karité sur les parties en insistant sur les points d'appuis.	Disposition pour le confort patient
Deuxième temps : Thorax, membres supérieurs et abdomen	
13. Enlever la chemise de nuit,	Disposition pour avoir accès aux sites de soin
14. Recouvrir le malade d'un drap,	Respect de la pudeur et mesures de protection
15. Commencer par le membre le plus éloigné du soignant et finir par celui qui est le plus près,	Disposition pour éviter contamination croisée
16. Découvrir la moitié du thorax jusqu'à l'ombilic,	Disposition pour avoir accès aux sites de soin et préservation de la pudeur du patient.
17. Savonner, rincer et essuyer en insistant plus particulièrement sur les plis et sous les seins. Lorsque la personne peut se tenir assise, il faut procéder à la toilette du dos dans le même temps	Disposition pour assurer l'hygiène de toutes ces parties et prévenir les lésions cutanées.
18. Coupler ce temps de toilette avec une manucure si nécessaire	
Troisième temps : Membres inférieurs	
19. Laver les cuisses, jambes et pieds en insistant bien entre les espaces interdigitaux,	Élimination des impuretés et transpirations des zones concernées
20. Rincer et sécher	
21. Appliquer la vaseline ou le beurre de karité au niveau du talon, de la malléole et des espaces interdigitaux	Disposition pour prévenir les escarres
22. Éviter de masser les mollets en cas de suspicion d'une phlébite	Prévention d'embolie
23. Profiter de l'occasion pour couper les ongles des orteils	Hygiène et prévention des lésions cutanées.
24. Changer l'eau des cuvettes.	Mesures d'hygiène
Quatrième temps : Toilette intime	
25. Mettre des gants à usage unique, elle se fait en respectant toujours la pudeur.	Mesure d'hygiène et de protection Respect de l'intimité du patient

Chez l'homme	
26. Nettoyer le pubis, l'intérieur des cuisses, puis le scrotum et la verge	Disposition pour assurer l'hygiène intime du patient.
27. Rincer, sécher dans le même ordre	Prévention irritations et infections
Chez la femme	
28. Mettre un bassin de lit sous les fesses,	Protection de la literie.
29. Savonner dans l'ordre le pubis, l'intérieur des cuisses, l'intérieur de la vulve, les petites lèvres les grandes lèvres, le périnée. (Lors de la toilette intime, ne jamais faire des mouvements avec le gant de l'anus vers la vulve)	Disposition pour assurer l'hygiène intime de la patiente.
30. Rincer à l'eau	
31. Sécher dans le même ordre en insistant sur les plis de l'aîne et la vulve,	
32. Enlever le bassin.	Confort et sécurité.
33. Changer l'eau des cuvettes.	Mesures d'hygiène
Cinquième temps : Toilette du dos et des fesses	
34. Installer le malade sur le côté	Mise en posture convenable pour réaliser le soin.
35. Procéder à la toilette du dos en le savonnant (si elle n'a pas été faite dans le 2ème temps)	Disposition pour assurer la toilette du dos.
36. Rincer avec de l'eau et sécher dans le même ordre	
37. Faire la prévention d'escarres aux points d'appuis qui sont : l'occiput, l'omoplate, le rachis.	Hygiène et prévention des lésions cutanées.
38. Procéder au lavage des fesses, après le lavage du dos et la prévention des escarres. (Si présence de selles, les nettoyer avec le papier toilette ou le papier absorbant avant d'entreprendre le soin)	Disposition pour la toilette du siège
39. Savonner les deux fesses et l'anus,	
40. Rincer, sécher et faire une prévention d'escarres au niveau du sacrum.	Hygiène et prévention des lésions cutanées
Sixième temps : Brossage des dents, coiffage et rasage	
41. Mettre une serviette sous le menton du malade	Protection du patient et de la literie
42. Présenter le matériel de brossage des dents et tenir le haricot ;	Disposition pour la réalisation de l'hygiène bucco-dentaire.
43. Mettre autour de son cou une serviette avant de peigner ses cheveux ;	Disposition pour la protection du patient

9. Laver les yeux sans savon avec un gant de toilette en allant de l'angle interne vers l'angle externe si l'œil n'est pas chassieux.	Respect de la technique nettoyage des yeux (élimination des sécrétions et impuretés, prévention des infections oculaires.)
10. Savonner le visage, le cou, les oreilles.	
11. Rincer, essuyer, en insistant sur les plis..	Élimination des impuretés, transpirations des zones concernées.
12. Appliquer la vaseline ou du beurre de karité sur les parties en insistant sur les points d'appui.	Disposition pour le confort patient
Deuxième temps : Thorax, membres supérieurs et abdomen	
13. Enlever la chemise de nuit,	Disposition pour avoir accès aux sites de soin
14. Recouvrir le malade d'un drap,	Respect de la pudeur et mesure de protection
15. Commencer par le membre le plus éloigné du soignant et finir par celui qui est le plus près,	Disposition pour éviter la contamination croisée
16. Découvrir la moitié du thorax jusqu'à l'ombilic,	Disposition pour avoir accès aux sites de soin et préservation de la pudeur du patient.
17. Savonner, rincer et essuyer en insistant plus particulièrement sur les plis et sous les seins. Lorsque la personne peut se tenir assise, il faut procéder à la toilette du dos dans le même temps	Disposition pour assurer l'hygiène de toutes ces parties et prévenir les lésions cutanées.
18. Coupler ce temps de toilette avec une manucure si nécessaire	
Troisième temps : Membres inférieurs	
19. Laver les cuisses, jambes et pieds en insistant bien entre les espaces interdigitaux,	Élimination des impuretés, transpirations des zones concernées.
20. Rincer et sécher	
21. Appliquer la vaseline ou le beurre de karité au niveau du talon, de la malléole et des espaces interdigitaux	Disposition pour prévenir les escarres
22. Éviter de masser les mollets en cas de suspicion d'une phlébite	Prévention d'embolie
23. Profiter de l'occasion pour couper les ongles des orteils	Hygiène et prévention des lésions cutanées.
24. Changer l'eau des cuvettes.	Mesures d'hygiène
Quatrième temps : Toilette intime	
25. Mettre des gants à usage unique, elle se fait en respectant toujours la pudeur.	Mesure d'hygiène et de protection Respect de l'intimité du patient

Chez l'homme	
26. Nettoyer le pubis, l'intérieur des cuisses, puis le scrotum et la verge	Disposition pour assurer l'hygiène intime du patient.
27. Rincer, sécher dans le même ordre	Prévention irritations et infections
Chez la femme	
28. Mettre un bassin de lit sous les fesses,	Protection de la literie.
29. Savonner dans l'ordre le pubis, l'intérieur des cuisses, l'intérieur de la vulve, les petites lèvres, les grandes lèvres, le périnée. (Lors de la toilette intime, ne jamais faire des mouvements avec le gant de l'anus vers la vulve)	Disposition pour assurer l'hygiène intime de la patiente.
30. Rincer à l'eau	
31. Sécher dans le même ordre en insistant sur les plis de l'aîne et la vulve,	
32. Enlever le bassin.	Confort et sécurité.
33. Changer l'eau des cuvettes.	Mesures d'hygiène
Cinquième temps : Toilette du dos et des fesses	
34. Installer le malade sur le côté	Mise en posture convenable pour réaliser le soin.
35. Procéder à la toilette du dos en le savonnant (si elle n'a pas été faite dans le 2ème temps)	Disposition pour assurer la toilette du dos.
36. Rincer avec de l'eau et sécher dans le même ordre	
37. Faire la prévention d'escarres aux points d'appui qui sont : l'occiput, l'omoplate, le rachis.	Hygiène et prévention des lésions cutanées.
38. Procéder au lavage des fesses, après le lavage du dos et la prévention des escarres. (Si présence de selles, les nettoyer avec le papier toilette ou le papier absorbant avant d'entreprendre le soin)	Disposition pour la toilette du siège
39. Savonner les deux fesses et l'anus,	
40. Rincer, sécher et faire une prévention d'escarres au niveau du sacrum.	Hygiène et prévention des lésions cutanées
Sixième temps : Brossage des dents, coiffage et rasage	
41. Mettre une serviette sous le menton du malade	Protection du patient et de la literie
42. Présenter le matériel de brossage des dents et tenir le haricot ;	Disposition pour la réalisation de l'hygiène bucco-dentaire.
43. Mettre autour de son cou une serviette avant de peigner ses cheveux ;	Disposition pour la protection du patient

44. Procéder au rasage chez les hommes si besoin	Rétablissement du confort
IV-A LA FIN DE LA TOILETTE	
45. Réinstaller le malade confortablement,	Réinstallation du client en position confortable
46. Remercier le malade pour sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir climat de confiance et de respect dans cette relation soignant-soigné
47. Consigner le soin sur la feuille de température ou de surveillance.	Communication et continuité de soins
48. Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité
49. Ouvrir les portes et les fenêtres	Maintien et/ ou restauration du confort du client
50. Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
V- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL	
51. Garder la peau propre et sèche	Prévention des irritations, de la macération et des infections cutanées.
52. Expliquer au patient et à sa famille l'importance de l'hygiène corporelle	Maintien des mesures de prévention et de confort
53. Signaler toute souillure de draps en dehors des heures de changements	

FICHE N°10 : SOINS DES CAVITES NATURELLES

Tâches	Contenus / justifications
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Plateau propre	Facilite l'organisation rationnelle du matériel et limite les risques de contamination.
Gants propres	Protègent le soignant et le patient contre les infections croisées
Eau propre ou sérum physiologique	Permettent le nettoyage ou le rinçage aseptique de la zone à soigner.
Compresse stériles ou propres,	Assurent un nettoyage efficace et préviennent l'introduction de germes.
Coton-tige (si autorisé),	Facilite le nettoyage précis des zones difficiles d'accès sans traumatisme.
Haricot	Permet de recueillir les déchets liquides ou solides pendant le soin.
Serviette propre	Protège les vêtements et le lit du patient contre les souillures.
Poubelle pour Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) ou Déchets Médicaux Infectieux (DMI)	Assure l'élimination sécurisée des déchets à risque infectieux selon les normes.

3- TECHNIQUE PROPREMENT DITE**A- SOINS DE LA CAVITÉ BUCCALE**

Se laver les mains	Prise de mesure d'asepsie
Sécher les mains et les passer à l'alcool à 60°	
Enfiler les gants	Protection du soignant et du patient
Informé le patient de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Installer le patient confortablement	Mise en posture adéquate pour la réalisation du soin.
Mettre une serviette sous le menton	Protection du patient et de la literie.
Changer les gants	Mesures d'hygiène et de protection.
Brosser les dents ou nettoyer la bouche avec compresse imbibée	Élimination des débris alimentaires et prévention des infections buccales.
Nettoyer la langue, les gencives et l'intérieur des joues	Maintien de l'hygiène bucco-dentaire.
Faire rincer la bouche et recracher dans le haricot	Confort et propreté du patient.
Retirer la serviette	
Retirer les gants	

B- SOINS DE LA CAVITÉ NASALE

Mettre des gants propres	Mesures d'hygiène.
Imbiber une compresse de sérum physiologique	Préparation du matériel.
Nettoyer l'entrée de chaque narine séparément	Élimination des sécrétions et prévention des infections.
Utiliser une compresse par narine	Prévention de la contamination croisée.
Sécher délicatement	Confort du patient.

C- SOINS DES OREILLES

Mettre des gants propres	Mesures d'hygiène.
Nettoyer uniquement le pavillon et l'entrée du conduit auditif	Prévention des lésions du tympan.
Utiliser une compresse propre par oreille	Prévention de la contamination croisée.
Sécher délicatement	Confort et prévention des irritations.

D- SOINS DES YEUX

Mettre des gants propres	Mesures d'asepsie.
Nettoyer les yeux sans savon	Prévention des irritations oculaires.

Aller de l'angle interne vers l'angle externe	Respect de la technique de nettoyage des yeux.
Utiliser une compresse par œil	Prévention de la contamination croisée.
Sécher délicatement	Confort du patient.
4- À LA FIN DU SOIN	
Installer le patient confortablement	Rétablissement du confort.
Retirer les gants et les jeter dans la poubelle DASRI	Respect des règles d'hygiène hospitalière.
Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission des infections.
Ranger et nettoyer le matériel	Maintien de l'environnement propre.
Consigner le soin si nécessaire	Communication et continuité des soins.
5- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL	
Expliquer l'importance de l'hygiène des cavités naturelles	Prévention des infections et maintien du confort.
Conseiller une hygiène quotidienne adaptée	Renforcement des bonnes pratiques de santé.
Inviter à signaler toute douleur ou anomalie	Détection précoce des complications.

FICHE N°11 : REFECTION DE LIT NON OCCUPE

TÂCHES	JUSTIFICATIONS
I. PREPARATION DU MATERIEL	
1. Disposer deux chaises dos à dos près du lit afin que les draps ne touchent pas la terre	Préservation du linge propre et réduction du risque de contamination.
2. Placer les couvertures sur les chaises	Disposition du matériel pour faciliter le soin.
II. TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
1. Mettre le drap de dessous sur le matelas et le traversin s'il en existe	Disposition pour stabiliser la literie
2. Faire les coins : rentrer la tête ou le pied, soulever le pan latéral et mettre sur le lit, enlever les plis, rentrer le rets, faire descendre le pan sur le lit, mettre sous le matelas, (recouvrir le traversin), bordé latéralement	Disposition pour la réalisation de la réfection de lit non occupé.
3. Mettre l'alèse sur cette toile cirée, border un côté puis tendre l'alèse et la toile cirée, border afin d'éviter les faux plis	
4. Placer la toile imperméable large à la hauteur du siège et sur le drap afin qu'elle puisse être bordée	Protection du matelas contre l'humidité et les souillures.
5. Disposer le drap de dessus à l'envers, l'étaler sur le lit (c'est l'endroit du drap qui est en contact avec le malade).	Disposition pour une couverture uniforme et correcte.
6. Border au pied, faire les coins, rouler le drap jusqu'au traversin sauf s'il s'agit d'un revers brodé ou repassé pour éviter de le froisser	Maintien du linge en place tout en respectant la finition esthétique.
7. Placer les couvertures une à une, en nombre suffisant selon les saisons ou l'état du malade, assez haut	Disposition pour une adaptation aux conditions climatiques et assurance d'un confort optimal.

TÂCHES	JUSTIFICATIONS
8. Placer d'abord la couverture en laine sur le drap de dessus puis en coton	Disposition pour une couverture convenable du lit.
9. Border drap et couverture au pied du lit et réaliser les angles	Fixation sécurisée et finition soignée.
10. Disposer les oreillers sur le traversin	Dispositions pour le confort du patient.
11. Rabattre le revers du drap de dessus sur les couvertures	
12. Eviter de border latéralement	Protection supplémentaire.
13. Mettre le couvre-lit	
14. Remettre tout en ordre dans la chambre du malade	Restauration de l'organisation de la chambre.
15. Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant

FICHE N°12 : REFECTION DE LIT OCCUPE

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Identifier le patient	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter au patient.	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient.	
Le rassurer de l'innocuité du geste.	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au patient s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire.	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le patient en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
Enfiler des gants propres	
Prendre un Chariot de soins ou plateau propre	Facilite l'organisation rationnelle du matériel et limite les contaminations
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Regrouper le linge propre sur un support décontaminé.	Organisation et respect de l'asepsie.
Installer le sac à linge sale sur son support.	Gestion rigoureuse du circuit du linge sale.
Préparer la solution hydro-alcoolique et les gants.	Prévention du risque infectieux.
S'équiper d'un tablier de protection.	Préservation de l'hygiène de la tenue professionnelle.

III. TECHNIQUE PROPREMENT DITE

Réaliser une friction hydro-alcoolique.	Prise de mesures d'asepsie
Régler le lit à hauteur de hanches et bloquer les roues.	Application de l'ergonomie et la stabilité du lit.
Desserrer le linge sale et retirer le dessus de lit.	Facilitation des manipulations ultérieures.
Placer le patient en décubitus latéral (barrière opposée levée).	Libération de la zone de travail sur le matelas.
Rouler le linge sale vers le milieu, sous le dos du patient.	Prise de mesures d'asepsie.
Nettoyer le matelas avec un détergent-désinfectant.	Prise de mesure d'asepsie.
Poser le linge propre roulé jusqu'au dos du patient.	Préparation de la nouvelle surface de couchage.
Basculer le patient sur le côté propre.	Transition pour finaliser le soin.

IV. CCSC (COMMUNICATION)

Enseigner sur l'importance de l'hygiène du lit.	Promotion de la santé et du bien-être.
Encourager la mobilisation autonome.	Prévention des complications de l'alitement.
Valoriser l'aide apportée par le patient.	Renforcement de l'estime de soi.
Échanger sur le ressenti et le confort final.	Évaluation de la qualité du soin prodigué.

Synthèse pour l'étudiant

Observation clinique : Durant le passage en décubitus latéral, effectuer systématiquement une inspection cutanée (recherche de rougeurs, érythèmes) au niveau du sacrum et des talons.

Transmissions : Consigner l'heure du soin, l'état de la peau, la tolérance du patient (douleur, fatigue) et son degré de collaboration dans le dossier de soins infirmier.

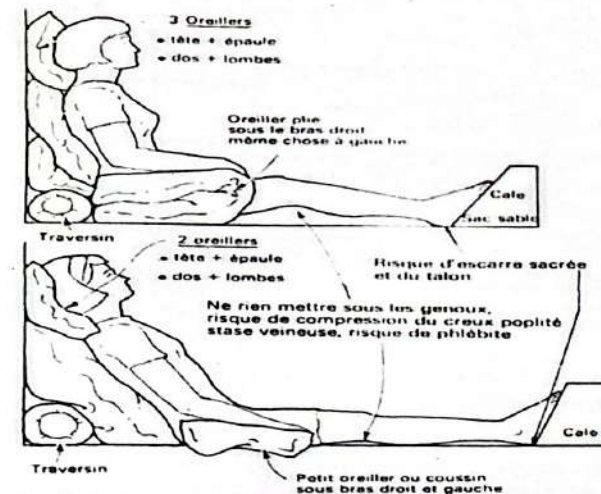
FICHE N°13 : INSTALLATION ET DIVERSES POSITIONS DU MALADE

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	Permet la compréhension du soin et favorise la collaboration
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Évite toute interruption du soin
Installer le malade en position confortable	Mise en condition favorable pour le soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
Enfiler des gants propres si nécessaire	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot de soins	Assure la sécurité et l'organisation du soin
Réunir le matériel nécessaire (coussins, alèze, draps...)	Évite les interruptions pendant le soin
Disposer le matériel aseptique en haut et sceptique en bas	Respect des règles d'hygiène
Prévoir un paravent ou rideau	Assure le respect de l'intimité du patient
Vérifier l'état du lit et des accessoires	Garantit la sécurité et le confort
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Informar le malade de l'imminence du soin	Préparation psychologique du patient
Fermer portes et fenêtres si nécessaire	Respect de l'intimité et prévention des courants d'air
Se faire aider si nécessaire	Sécurité du patient et du soignant
Prendre connaissance des indications et contre-indications	Adaptation du soin à l'état du patient

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
Évaluer l'état du patient (conscience, mobilité, tolérance)	Permet une installation adaptée
Observer l'état cutané (zones à risque d'escarres)	Prévention des escarres
Proposer au patient de vider sa vessie	Confort et prévention des interruptions
Expliquer les principes de l'installation	Favorise la coopération
Rassurer le patient	Diminue la peur et l'anxiété
Bloquer les roues du lit et ajuster la hauteur	Sécurité et ergonomie du soin
Utiliser les techniques de manutention adaptées	Prévention des lombalgies et des accidents
Demander au patient de participer si possible	Favorise l'autonomie
Effectuer la mobilisation (translation, retournement...)	Installation correcte du patient
Surveiller les réactions du patient	Détection précoce de complications
Installer selon la position indiquée (fauteuil, décubitus...)	Assure confort et efficacité thérapeutique
Ajuster les coussins et supports	Prévention des points de pression
Mettre les objets à portée de main (appel, bassin...)	Favorise l'autonomie
Réinstaller le patient confortablement	Prévention de l'inconfort
Surveiller l'alignement du corps	Prévention des douleurs et déformations
Noter dans le dossier de soins (heure, position)	Assure la traçabilité
Noter l'état de la peau et les réactions	Suivi du patient
Ranger le matériel	Maintien de l'environnement propre
Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission des infections
INSTALLATION AU FAUTEUIL	
Installer le fauteuil à côté du lit et bloquer les roues	Sécurité du patient

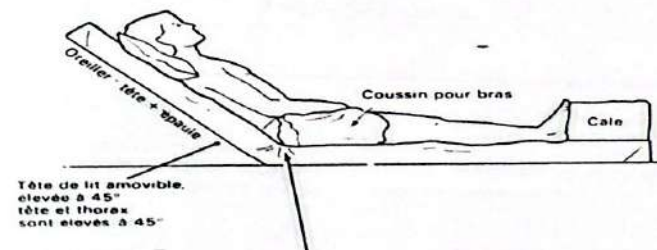
TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
Aider le patient à s'asseoir puis au fauteuil	Prévention des chutes
Placer des coussins (cervicales, lombaires)	Respect de la posture
Positionner les pieds correctement	Évite le glissement
DÉCUBITUS DORSAL	
Installer le patient sur le dos avec oreiller	Confort
Surélever les talons	Prévention des escarres
Maintenir les pieds à 90°	Prévention des déformations
Installer les barrières de lit	Prévention des chutes
DÉCUBITUS VENTRAL	
Installer le patient sur le ventre	Indication thérapeutique
Positionner la tête sur le côté	Confort respiratoire
Placer coussins sous genoux et chevilles	Réduction des pressions
DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL (3/4)	
Installer le patient sur le côté	Réduction des points d'appui
Placer coussins (dos, jambes, bras)	Maintien et confort
Aligner le corps correctement	Prévention des douleurs
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'importance du changement de position régulier	Prévention des escarres et amélioration de la circulation
Conseiller de signaler toute douleur ou inconfort	Intervention rapide
Sensibiliser à la bonne installation au lit et au fauteuil	Amélioration du confort
Encourager la participation du patient selon ses capacités	Favorise l'autonomie
Informar sur les risques liés à l'immobilité	Prévention des complications

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
Expliquer l'utilité des coussins et supports	Réduction des pressions
Conseiller la famille sur l'aide au repositionnement	Continuité des soins
Sensibiliser à l'hygiène du patient et du lit	Prévention des infections
Encourager le respect des consignes médicales	Sécurité du patient



ux variables médicales :

- Il en existe deux variations médicales :
- la position de Fowler
 - et
 - la position semi-Fowler



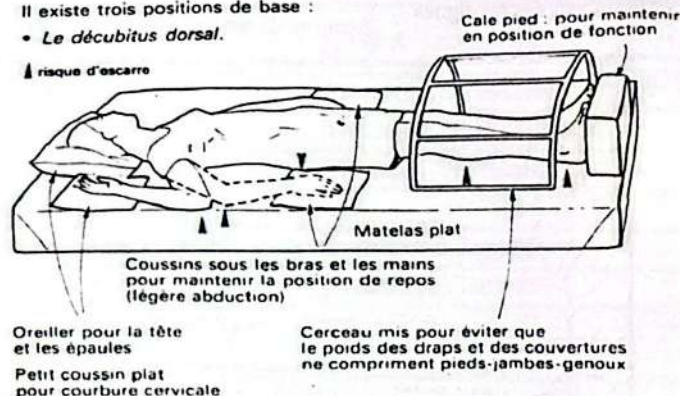
Les positions assises et demi-assises, ainsi que celles de Fowler, sont essentiellement utilisées dans les affections des appareils respiratoires et cardiovasculaires : dyspnée... afin de permettre une meilleure extension pulmonaire.

b) Les positions allongées.

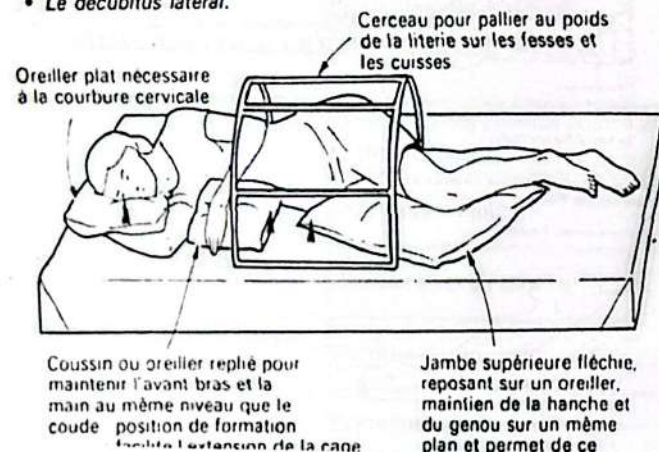
Il existe trois positions de base :

• Le décubitus dorsal.

▲ risque d'escarre



• Le décubitus latéral.



FICHE N°14 : PREVENTION DES ESCARRES

TACHES	CONTENUS /JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
1- Se rendre au chevet du lit du client	Vérification de la présence effective du client
2- Identifier le client	Identification du client et prise de connaissance de son diagnostic médical
3- Saluer le client avec amabilité	Manifestation de courtoisie et d'empathie au client
4- Se présenter au client	Identification du soignant par le client
5- S'informer sur son état de santé	Suivi de l'évolution de l'état de santé du client
6- Lui expliquer le soin	Obtention de la confiance et de l'adhésion du client
7- Rassurer le client	Mise en confiance du client
8- Évaluer l'état de santé du client	Identification des besoins du client en vue de la préparation du soin
9- Rechercher d'éventuelles lésions cutanées	Adaptation des soins
10- Se laver les mains et les assécher	Prise de mesures d'asepsie
II- REUNION DU MATERIEL	
11-Prévoir un chariot à 3 étages à défaut 2 étages	Préparation du chariot pour le matériel
12-Prévoir 2 draps	Disponibilité de draps pour un changement éventuel
13-Prévoir de petits oreillers	Disponibilité pour usage approprié
14-Prévoir des gants propres	Prise de mesures de protection
15-Prévoir un haricot	Gestion des déchets de soins
16-Prévoir de l'alcool et du coton	Prise de mesures d'asepsie
17-Prévoir des compresses	Réalisation de pansement
18-Prévoir un savon aseptique	Mesures d'hygiène des mains
19-Prévoir un plateau stérile	Prise de mesures d'asepsie
Prévoir des serviettes jetables	Mesures d'hygiène des mains
20-Prévoir une couverture	Protection du client
21-Prévoir un seau d'eau tiède	-
22-Prévoir un savon doux et une serviette	Disposition du nécessaire pour la toilette du client
23-Prévoir un sac à poubelle	Gestion des déchets
24-Prévoir une solution émolliente (vaseline ou beurre de karité)	Disposition du matériel pour le massage le client
25-Prévoir une alèse	Mesures de protection du client
26-Nettoyer le chariot	Mesures d'hygiène

27-Disposer le matériel sur le chariot	Préparation du matériel
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
28-Solliciter une aide	Sollicitation d'aide pour assurer l'efficacité et l'efficacité du soin
29-Fermer portes et fenêtres	Protection de l'intimité du client
30-Prévenir le client de l'imminence du soin	Disposition pour favoriser les soins
31-Mettre le paravent	Protection de l'intimité du client
32-Se laver les mains et les assécher	Mesures d'hygiène
33-Demander à l'aide de faire autant	
34-Porter des gants propres	Mesures d'hygiène et de protection : soignant et du client
35-Demander à l'aide de se mettre du côté opposé du lit	Facilitation de la réalisation du soin
36-Enrôler l'alèse dans le sens de la longueur	Protection de la literie
37-Installer le client en décubitus latéral face à l'aide	Identification des points de prédilection des escarres
38-Demander à l'aide de maintenir le client dans cette position	Disposition appropriée pour éviter la chute du client
39-Poser l'alèse sur le lit	Protection de la literie
40-Dérouler l'alèse jusqu'à buter au niveau du dos du client	
41-Mettre le client en décubitus latéral en donnant dos à l'aide	Mise en posture convenable pour identifier d'éventuelles lésions
42-Maintenir le client dans cette position	Disposition appropriée pour éviter la chute du client
43-Demander à l'aide de dérouler l'alèse	Mesures de protection
44-Remettre le client en décubitus latéral face à l'aide	Mise en posture convenable pour identifier d'éventuelles lésions
45-Border l'alèse	Maintien de la stabilité du drap pour le confort du client
46-Remettre le client en décubitus latéral du côté de l'aide	Mise en posture convenable pour identifier d'éventuelles lésions
47-Demander à l'aide de maintenir le client dans cette position	Disposition appropriée pour éviter la chute du client
48-Prendre le gant de toilette	Disposition Pour réaliser la toilette
49-Mouiller et savonner le gant	Disposition pour le nettoyage des lieux de prédilection des escarres
50-Nettoyer les zones d'appui en fonction de la position du client :	
50a-En décubitus dorsal : occiput, omoplate, coude, coccyx, sacrum, talon	

50b-En décubitus latéral : épaule, joue, côtes, hanche, grand trochanter, malléole externe, genoux	Réalisation des soins aux sites de prédilection des escarres
50c-En décubitus ventral : genoux, orteils, seins chez la femme, pénis chez l'homme.	
51-Rincer le gant	Propreté du gant
52-Essuyer les différentes zones avec le gant selon l'ordre de nettoyage	Assèchement des zones d'appui (Pour éviter l'humidité et rendre les zones disposées au massage)
53-Assécher les zones avec la serviette	Restauration de la consistance de la peau et prévention de l'irritation au niveau des zones d'appui
54-Appliquer la vaseline ou le beurre de karité aux zones d'appui	Amélioration de la circulation sanguine au niveau des points d'appui (Pour soulager la pression, stimuler la circulation sanguine au niveau de l'organisme, prévenir l'irritation de la peau)
55-Masser jusqu'à la disparition du produit	Prise de mesures d'hygiène et de protection
56-Faire autant pour les autres zones en suivant l'ordre de nettoyage	Prise de mesures de prévention de godets
57-Retirer l'alèse en l'enroulant de l'extérieur vers l'intérieur	Surveillance des soins éventuels en cours
58-Tirer sur le drap	Réinstallation du client en position confortable
59-Vérifier éventuellement le fonctionnement des sondes et des perfusions	Prise de mesures de prévention d'ulcération au niveau des malléoles et du genou
60-Réinstaller le client	Protection du client contre les courants d'air
61-Interposer les petits oreillers entre les genoux et les malléoles	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
62-Couvrir le client	
63-Ôter les gants	
64-Se laver les mains et les assécher	
65-Demander à l'aide de faire autant	
66-Établir un cycle de changement de position	Mobilisation planifiée du patient
67-Noter le soin	Continuité et la coordination des soins
68-Ouvrir portes et fenêtres	Maintien et/ ou restauration du confort du client

IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)

69-Expliquer au client et/ou à sa famille l'intérêt d'une bonne alimentation	Prescription et conseil du régime alimentaire adapté (alimentation riche en protéine par exemple)
70-Apprendre au client à faire les changements de positions même mineurs dans le lit toutes les 30 minutes	Enseignement au client et / ou à sa famille des mesures de self care (Pour assurer la vascularisation permanente des zones de prédilection)
71-Conseillers à la famille de signaler toute souillure de draps en dehors des heures de changements	Maintien des mesures de prévention
72-Expliquer au client l'importance de l'hygiène corporelle	

5-RANGEMENT DU MATERIEL

73-Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
-----------------------------------	---

Poste de lavage : Vérifier la présence d'un lavabo propre et dégagé. Évite les interruptions durant le soin : limite les projections de germes.

Savon : S'assurer de la présence d'un savon doux liquide (non antiseptique). Le savon liquide est plus hygiénique qu'un savon solide. Le savon doux préserve l'intégrité de la barrière cutanée.

Essuie-mains : Vérifier le distributeur de papier à usage unique. Le papier jetable est le seul garant d'un séchage aseptique (les serviettes en tissu sont des nids à bactéries).

Collecteur de déchets : Vérifier que la poubelle est munie d'une pédale fonctionnelle. Permet l'élimination des déchets sans contact manuel après le lavage.

FICHE N°15 : LE LAVCHESAGE SIMPLE DES MAINS

Taches	Justifications
I- PREPARATION DU MATERIEL	
Poste de lavage : Vérification de l'état du lavabo et de la disponibilité des produits.	Prévention des interruptions et limitation des projections.
Savon : Utilisation d'un savon doux liquide de préférence.	Hygiène du contenant et préservation de l'intégrité cutanée.
Essuie-mains : Approvisionnement en papier à usage unique.	Garantie d'un séchage aseptique et absence de nids bactériens.
Collecteur : Utilisation d'une poubelle à pédale.	Évitement de tout contact manuel post-lavage.

II - TECHNIQUE PROPREMENT DITE **CONTENUS/ JUSTIFICATIONS**

Préliminaire : Retrait des bijoux, montres et dégagement des poignets.	Élimination des réservoirs de germes et accessibilité totale des zones à traiter.
Mouillage : Ouverture du robinet et humidification à l'eau tiède.	Préparation de l'émulsion et tolérance épidermique.
Délivrance : Prélèvement d'une dose de savon.	Adéquation de la quantité pour une couverture optimale.
Friction (30s) : Action mécanique sur les paumes, dos, espaces interdigitaux et poignets.	Détachement physique des souillures et de la flore transitoire.

II - TECHNIQUE PROPREMENT DITE	CONTENUS/ JUSTIFICATIONS
Rinçage : Écoulement de l'eau des doigts vers les poignets.	Élimination des résidus par gravitation du plus propre vers le moins propre.
Séchage : Tamponnement avec le papier des doigts vers les poignets.	Prévention de la prolifération bactérienne et protection contre les irritations.
Fermeture : Usage de l'essuie-mains pour fermer le robinet.	Protection contre la re-contamination immédiate.
Élimination : Jet du papier dans le collecteur via la pédale.	Maintien de l'asepsie finale du geste.

FICHE N°16 : LAVAGE CHIRURGICAL DES MAINS

Taches	Justifications
I. PREPARATION DU MATERIEL La préparation doit être rigoureuse pour éviter toute interruption une fois la procédure entamée.	
Poste de lavage (Bac à commande non manuelle)	Évite la recontamination des mains par contact avec les robinets.
Savon antiseptique (ex: Povidone iodée ou Chlorhexidine)	Assure une action bactéricide, fongicide et virucide avec un effet rémanent.
Brosse à ongles stérile à usage unique	Permet une action mécanique ciblée sur les zones de forte charge bactérienne.
Essuie-mains stériles (en paquet individuel)	Garantit l'absence de micro-organismes lors du séchage final.
Tenue de bloc complète (Pyjama, coiffe, masque)	Limite la dispersion de squames et de gouttelettes dans l'environnement.

III. TECHNIQUE PROPREMENT DITE (PROCEDURE EN 3 PHASES)
 Le respect de la chronologie et des temps de contact est impératif pour l'efficacité de l'antiseptie.

Taches	Justifications
Prélavage : Mouiller mains et avant-bras. Appliquer le savon, masser 1 min en allant des mains vers les coudes. Rincer.	Élimine la souillure macroscopique et prépare la peau à l'action de l'antiseptique.
Phase 1 (Brossage) : Prendre la brosse stérile, l'imprégner de savon. Brosser les ongles (30 sec par main). Jeter la brosse.	Les espaces sous-unguéaux sont des réservoirs de germes que seule l'action mécanique peut déloger.

Phase 2 (Lavage principal) : Savonner mains, espaces interdigitaux, poignets et avant-bras jusqu'aux coudes pendant 2 min.	Temps nécessaire pour réduire la flore résidente de manière significative.
Rinçage intermédiaire : Rincer abondamment en gardant les mains hautes.	L'eau doit toujours couler du plus propre (doigts) vers le moins propre (coudes).
Phase 3 (Finition) : Nouveau savonnage des mains et poignets uniquement pendant 2 min.	Renforce la charge antiseptique sur la zone la plus proche du champ opératoire.
Rinçage final et Séchage : Rincer. Sécher par tamponnement avec un champ stérile, de la main vers le coude.	Le séchage complet évite la macération sous les gants et l'irritation cutanée.

III. Communication pour le Changement de Comportement (CCSC)

L'aspect technique ne doit pas occulter la dimension humaine. La CCSC ici vise à rassurer le patient et à l'impliquer dans la sécurité des soins.

- **Accueil et Salutations** : Avant d'entrer en zone de lavage, saluer le patient s'il est conscient. "Bonjour M. [Nom], je suis l'infirmier(e) qui va s'occuper de vous. Je vais maintenant préparer mes mains pour garantir une hygiène maximale durant l'intervention."
- **Information et Éducation** : Expliquer brièvement l'importance du geste. "Ce lavage est très spécifique, il dure plusieurs minutes pour éliminer tous les microbes invisibles. C'est une barrière de sécurité pour votre santé."
- **Rassurance active** : Utiliser un ton calme et professionnel. Le fait que le patient voit ou entende le soignant se préparer rigoureusement diminue son anxiété face au risque d'infection.
- **Valorisation de l'hygiène** : Si le patient pose des questions sur ses propres mains ou son hygiène pré-opératoire, valider ses efforts ("C'est excellent que vous ayez pris votre douche avec le savon spécifique ce matin, cela complète mon action").

FICHE N°17 : PORT ET RETRAIT DES GANTS

Tâches	Contenus / justifications
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	Obtention de l'adhésion du patient.
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains	Mesures d'asepsie.
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Prendre un lateau ou le chariot si nécessaire	Facilite l'organisation rationnelle du matériel
Gants propres (non stériles)	Protègent le soignant et le patient lors des soins non invasifs.
Gants stériles	Assurent l'asepsie lors des soins nécessitant un champ stérile.
Solution hydro-alcoolique	Permet l'hygiène des mains avant et après le port des gants.
Eau propre et savon	Assurent un lavage efficace des mains pour réduire la flore microbienne.
Essuie-mains propre ou papier à usage unique	Permet le séchage hygiénique des mains après lavage.
Poubelle pour DASRI ou DMI	Assure l'élimination sécurisée des gants contaminés conformément aux règles d'hygiène.
Sac poubelle ordinaire	Permet l'élimination des déchets non contaminés.
Paravent ou rideau (si nécessaire)	Assure le respect de l'intimité du patient pendant le soin.

III- TECHNIQUE DE PORT DES GANTS PROPRES (NON STÉRILES)

Réaliser l'hygiène des mains	Prévention de la transmission des micro-organismes.
Sortir les gants de la boîte sans toucher l'extérieur	Limitation de la contamination.
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient.

IV- TECHNIQUE DE PORT DES GANTS STÉRILES

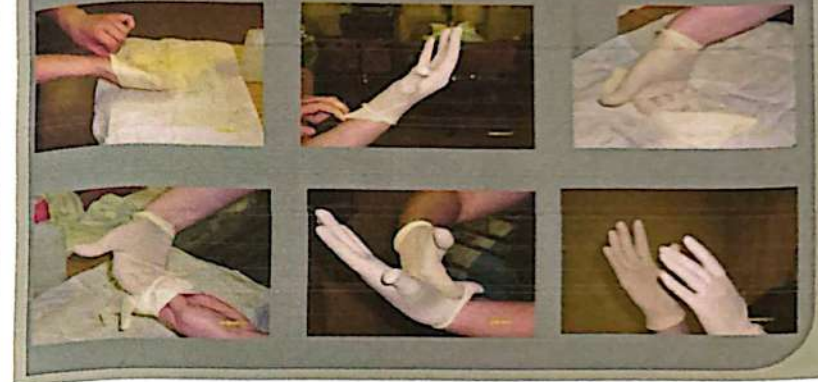
Installer le champ stérile sur le plateau ou le chariot	Maintien de la stérilité.
Ouvrir l'emballage stérile correctement	Prévention de la contamination.
Enfiler les gants selon la technique stérile	Respect de l'asepsie.

V- ÔTER DES GANTS CONTAMINÉS

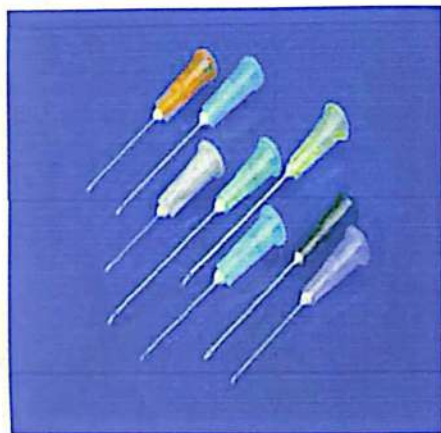
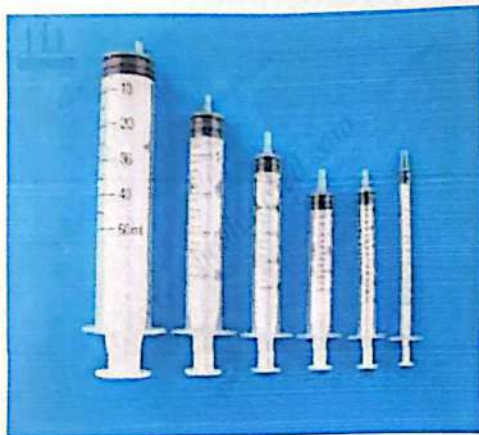
Retirer les gants selon la technique	Prévention de la contamination croisée.
Jeter les gants dans la poubelle DASRI	Respect des règles d'hygiène hospitalière.
Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission des infections.

VI- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL

Sensibiliser à l'hygiène des mains	Prévention des infections associées aux soins.
Expliquer le bon usage des gants	Les gants ne remplacent jamais le lavage des mains.

Enfiler les gants stériles**RETRAIT DE GANTS CONTAMINÉS**

III- SOINS MÉDICAUX



FICHE N°18 : INJECTION INTRADERMIQUE

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (seringue à tuberculine, aiguille fine, produit prescrit, compresse, antiseptique, plateau, boîte de sécurité, support de prescription)
Oter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Vérifier la prescription médicale	Sécurité du patient et respect de la prescription
Installer et découvrir la zone d'injection (face antérieure de l'avant-bras)	Disposition pour la réalisation du soin
Choisir le site d'injection	Choix d'une zone pauvre en poils et en lésions cutanées
Désinfecter la peau du centre vers la périphérie	Réduction du risque d'infection

Laisser sécher l'antiseptique	Obtention de l'efficacité optimale du produit antiseptique
Tendre la peau avec le pouce	Facilite l'introduction de l'aiguille dans le derme
Introduire l'aiguille presque parallèlement à la peau, biseau vers le haut	Administration du produit dans le derme
Injecter lentement le produit	Formation d'une papule témoin de la bonne injection
Retirer délicatement l'aiguille sans masser	Évite la diffusion du produit hors du derme
Appliquer une compresse sèche sans appuyer fortement	Protection du point d'injection
Éliminer immédiatement l'aiguille dans la boîte de sécurité	Prévention des accidents d'exposition au sang
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client de ne pas gratter ni masser la zone injectée	Prévention des réactions locales
Informar sur la possibilité d'une petite papule ou rougeur	Information normale liée au test ou au produit injecté
Conseiller de revenir pour la lecture du test si nécessaire	Disposition pour l'interprétation correcte du résultat
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné

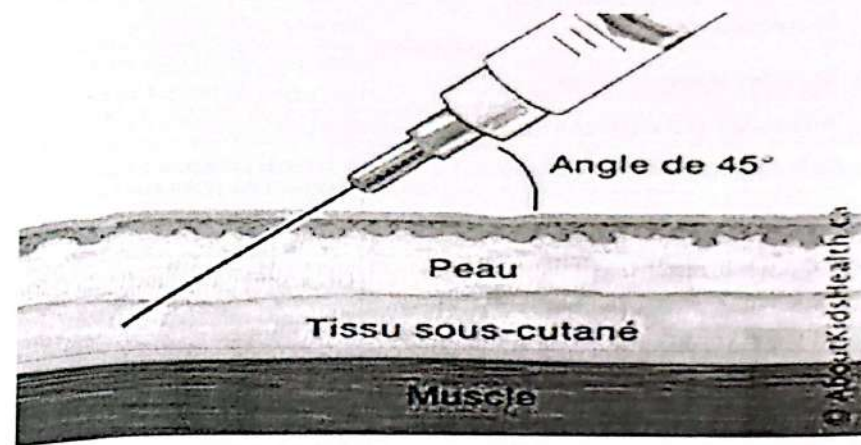
FICHE N°19 : INJECTION SOUS-CUTANÉE (SC)

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (seringue stérile, aiguille sous-cutanée, produit prescrit, compresse, antiseptique, plateau, boîte de sécurité, support de prescription)
Oter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informar le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Vérifier la prescription médicale	Sécurité du patient et respect de la prescription
Installer et découvrir la zone d'injection	Disposition pour la réalisation du soin
Choisir le site d'injection (abdomen, face externe du bras, cuisse)	Choix d'une zone riche en tissu sous-cutané
Désinfecter la peau du centre vers la périphérie	Réduction du risque d'infection

Laisser sécher l'antiseptique	Obtention de l'efficacité optimale du produit antiseptique
Former un pli cutané entre le pouce et l'index	Mise en évidence du tissu sous-cutané
Introduire l'aiguille dans le pli cutané	Administration du médicament dans le tissu sous-cutané
Injecter lentement le produit	Favorise la diffusion du médicament et diminue la douleur
Retirer l'aiguille et relâcher le pli cutané	Limitation du traumatisme tissulaire
Appliquer une compresse sèche sans masser	Prévention des lésions locales
Éliminer immédiatement l'aiguille dans la boîte de sécurité	Prévention des accidents d'exposition au sang
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation

IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)

Expliquer au client l'importance du respect des heures d'injection	Disposition pour l'efficacité du traitement
Conseiller la rotation des sites d'injection	Prévention des complications locales
Conseiller de signaler toute réaction anormale	Dépistage précoce des effets indésirables
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné



FICHE N°20 : INJECTION INTRAMUSCULAIRE (IM)

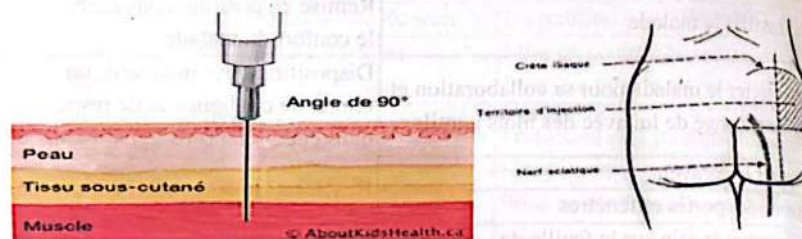
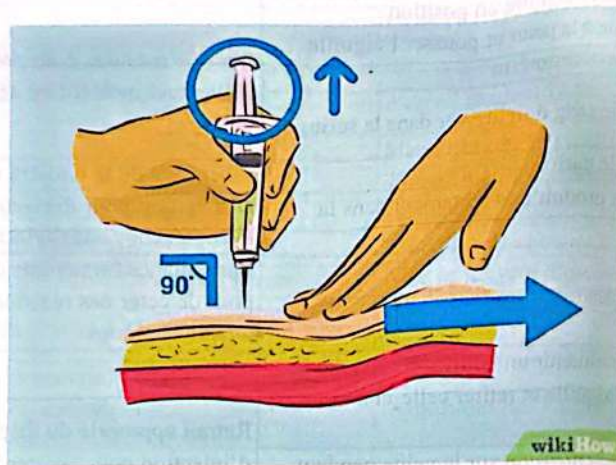
TACHES	CONTENUS/ JUSTIFICATIONS
IV- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
1. Accueillir le malade si soins ambulatoire ou Identifier le malade si patient hospitalisé	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de son diagnostic médical
2. Se présenter au patient	
3. Expliquer le soin au patient	Obtention, de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
1. Se laver les mains à l'eau et au savon	Se laver les mains à l'eau et au savon
2. Prendre un chariot à deux niveaux	Disposition pour assurer la sécurité du soin
3. Disposer le matériel aseptique à l'étage supérieur et le matériel sceptique à l'étage inférieur	Disposition rationnelle du matériel de soin
4. Aller au lit du patient	Disposition pour réaliser le soin
III-TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
1. Informer le client de l'imminence du soin	Mise en confiance pour faciliter le soin
2. Installer le malade dans une position confortable	Mise en posture convenable pour favoriser le soin
3. Fermer portes et fenêtres	Prise de mesures pour le respect de l'intimité du patient
4. Mettre le paravent si chambre commune	
5. Se laver les mains et les passer à l'alcool ou porter des gants stériles	Prise de mesure d'asepsie
6. Prendre un tampon d'alcool et	
7. Délimiter la zone à injecter (quart supérieur et externe de la fesse)	
8. aseptiser la peau	
9. Prendre la seringue et purger l'air	
10. Tendre la peau avec le pouce et l'index ou le majeur d'une main	

11. Tenir d'une main, la seringue perpendiculairement à la peau	Disposition pour faciliter la pénétration de l'aiguille dans le muscle
12. Piquer et enfoncer rapidement l'aiguille dans toute sa longueur	Disposition pour l'administration entière du produit
13. Aspirer pour vérifier que l'aiguille ne se trouve pas dans un vaisseau sanguin	Prise de mesures pour prévenir d'éventuel incident ou accident
14. Injecter le liquide lentement et totalement,	Prévention d'un éventuel choc anaphylactique
15. surveiller les réactions du patient	Surveillance immédiate du patient pour détecter des réactions anaphylactiques
16. Poser et maintenir un tampon d'alcool à la base de l'aiguille et retirer celle-ci rapidement	Retrait approprié du dispositif d'injection pour assurer l'hémostase
17. Obturer l'orifice de la piqûre en tamponnant avec le coton alcoolisé	
18. Remercier de sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans cette relation soignant-soigné
19. Réinstaller le malade	Remise en position convenable pour le confort du malade
20. Retirer le paravent	Restauration du confort du patient
21. Ouvrir les portes et fenêtres	
22. Consigner le soin sur la feuille de température ou de surveillance	Communication et continuité du soin
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
23. Informer le patient de ne pas manipuler site d'injection	Prévention d'éventuelles infections post injection
24. Signaler tout malaise au soignant	Gestion des effets secondaires
25. Faire un feed-back de la CCSC	Vérification de la perception du message
26. Se laver les mains	Mesure d'hygiène et de protection
27. Faire un feed-back du message	Evaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)

FICHE N°21 : INJECTION INTRA VEINEUSE (IV)

TACHES	CONTENU / JUSTIFICATION
I-PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
1. Accueillir le malade	Accueil et identification du malade
2. Identifier le malade	
3. Se présenter à lui	Manifestation de courtoisie et d'empathie pour des soins humanisés
4. Expliquer le soin au malade	
II- PREPARATION DU MATERIEL	
1. Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
2. Prendre un chariot à deux niveaux	Préparation du chariot pour le matériel
3. Disposer le matériel aseptique à l'étage supérieur et le matériel sceptique à l'étage inférieur	Disposition rationnelle du matériel
4. Aller au lit du client	Déplacement vers le malade pour la réalisation du soin
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
1. Informer le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer le soins
2. Installer le malade dans une position confortable	Mise en posture convenable pour favoriser le soin
3. Fermer portes et fenêtres	Protection de l'intimité du patient
4. Mettre le paravent si chambre commune	
5. Se laver les mains et les passer à l'alcool ou porter des gants stériles	Prise de mesures d'asepsie
6. Placer le garrot, ne pas trop serrer, le pouls doit rester perceptible	Mise en évidence des veines
7. Prendre un tampon d'alcool	Prise de mesures d'asepsie
8. Aseptiser la peau au niveau du pli du coude	
9. Tenir le bras à pleine main et le mettre en extension	Immobilisation de la veine
10. Saisir la seringue en maintenant le biseau de l'aiguille tourné vers le haut	Maintien de la seringue et l'aiguille dans la position convenable
11. Repérer la veine	Sélection de la veine à ponctionner
12. Empaumer le coude, tendre la peau et immobiliser la veine avec le pouce	
13. Appuyer l'aiguille au centre de la veine	

14. Perforer la peau et la veine en angle aigu	Disposition pour une bonne injection intraveineuse
15. Mettre alors l'aiguille en position tangentielle à la peau et pousser l'aiguille d'un à deux centimètre	Prise de mesures pour prévenir d'éventuel incident ou accident
16. Aspirer ; le sang doit arriver dans la seringue	
17. Détacher le garrot	Libération de la lumière veineuse
18. Injecter le produit très lentement dans la veine	Disposition pour Prévenir un éventuel choc anaphylactique
19. Observer les réactions du patient	Surveillance immédiate du patient pour détecter des réactions anaphylactiques
20. Poser et maintenir un tampon d'alcool à la base de l'aiguille et retirer celle-ci à la fin de l'injection	Retrait approprié du dispositif d'injection pour assurer l'hémostase
21. Maintenir la pression sur la veine pendant quelques instants, pour éviter l'écoulement du sang	
22. Réinstaller le malade	Remise en position convenable pour le confort du malade
23. Remercier le malade pour sa collaboration et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans cette relation soignant-soigné
24. Retirer le paravent	Restauration du confort du malade
25. Ouvrir les portes et fenêtres	
26. Consigner le soin sur la feuille de température ou de surveillance	Communication et continuité du soin
27. Se laver les mains	Mesure d'hygiène pour la sécurité
28. Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV. COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL(CCSC)	
Informé le client de ne pas manipuler le site d'injection	Prévention d'éventuelle infection post injection
Signaler tout malaise au soignant	Maintien des mesures de prévention et de confort



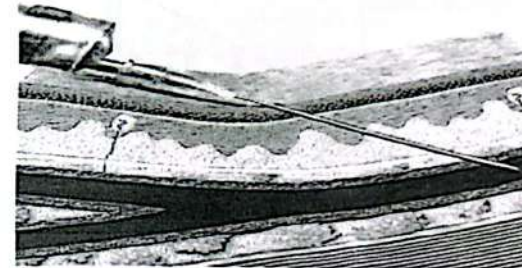
FICHE N°22 : PERFUSION INTRA VEINEUSE SIMPLE

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (couché ou semi-assis)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (solution prescrite, perfuseur, cathéter IV, garrot, antiseptique, compresses, sparadrap, plateau, boîte de sécurité, potence, support de prescription)
Ôter les gants	Prévention de la contamination croisée
III-TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Vérifier la prescription médicale	Sécurité du patient et respect de la prescription
Installer le matériel et purger le perfuseur	Élimination de l'air pour éviter une embolie gazeuse

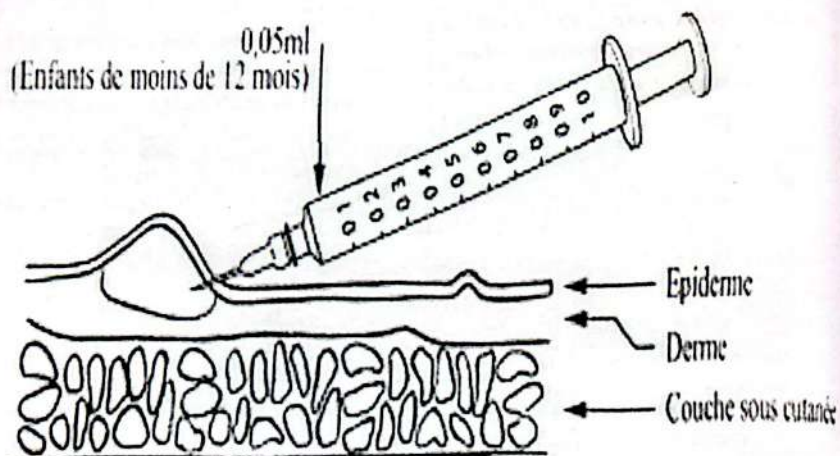
Choisir une veine périphérique adaptée	Disposition pour une perfusion efficace et sécurisée
Poser le garrot au-dessus du site choisi	Favorise la dilatation veineuse
Désinfecter la peau du centre vers la périphérie	Réduction du risque d'infection
Laisser sécher l'antiseptique	Obtention de l'efficacité optimale du produit antiseptique
Introduire le cathéter dans la veine	Mise en place de la voie veineuse périphérique
Retirer le mandrin et desserrer le garrot	Rétablissement de la circulation sanguine
Raccorder le perfuseur au cathéter	Permet l'administration de la solution prescrite
Ouvrir le débit et régler la vitesse d'écoulement	Respect de la prescription médicale
Fixer le cathéter avec un sparadrap	Maintien du dispositif en place
Installer confortablement le membre perfusé	Prévention des déplacements du cathéter
Surveiller le point de ponction et l'écoulement	Dépistage précoce des complications (infiltration, douleur, œdème)
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client l'importance de ne pas plier le bras perfusé	Prévention du déplacement du cathéter
Informé sur la durée prévue de la perfusion	Participation du patient au soin
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné

• Région d'élection

- Veine de la région du pli du coude
- Veine du dos de la main



FICHE D'APPRENTISSAGE A L'USAGE DE L'APPRENANT, POUR LA REALISATION D'UNE



FICHE N°23 : TRANSFUSION SANGUINE

Tâches	Contenus / justifications
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (couché ou semi-assis)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (produit sanguin labile prescrit, dispositif de transfusion avec filtre, soluté isotonique, cathéter IV, garrot, antiseptique, compresses, sparadrap, plateau, pied à perfusion, tensiomètre, thermomètre, stéthoscope, boîte de sécurité, support de prescription)
Ôter les gants	Prévention de la contamination croisée
III - TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins

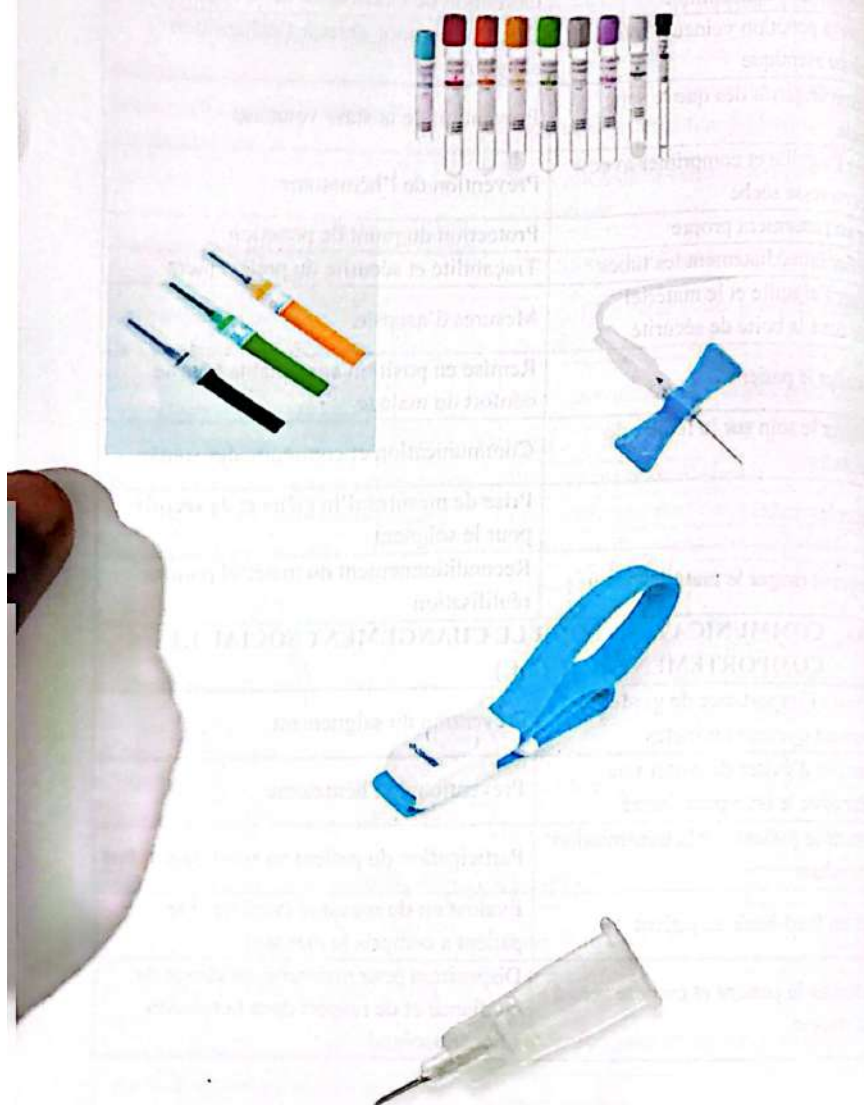
Vérifier la prescription médicale	Sécurité du patient et respect de la prescription
Contrôler l'identité du patient avec le produit sanguin	Prévention des accidents transfusionnels
Vérifier la date de péremption et l'aspect du produit sanguin	Sécurité transfusionnelle
Prendre les paramètres vitaux avant la transfusion	Disposition pour une transfusion efficace et sécurisée
Installer et purger le dispositif de transfusion avec le soluté isotonique	Élimination de l'air et préparation du dispositif
Choisir une veine périphérique adaptée	Disposition pour une transfusion efficace et sécurisée
Poser le garrot et désinfecter la peau	Préparation du site de ponction
Introduire le cathéter dans la veine	Mise en place de la voie veineuse
Retirer le mandrin et desserrer le garrot	Rétablissement de la circulation sanguine
Raccorder le dispositif de transfusion au cathéter	Disposition pour l'administration du produit sanguin
Démarrer lentement la transfusion	Détection précoce des incidents transfusionnels
Surveiller étroitement le patient pendant les premières minutes	
Régler le débit selon la prescription	Respect de la prescription médicale
Surveiller régulièrement les paramètres vitaux	Dépistage des complications
Observer le point de ponction	Prévention des infiltrations et complications locales
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient

Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Éliminer le matériel selon les règles en vigueur	Prévention des risques infectieux
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client de signaler immédiatement tout frisson, fièvre ou malaise	Dépistage précoce des réactions transfusionnelles
Informé sur l'importance de rester au repos pendant la transfusion	Prévention des complications
Rassurer le patient sur la surveillance continue	Renforcement de la confiance
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné

FICHE N°24 : PRELEVEMENT SANGUIN

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et sécurisation du soin
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient
Expliquer le soin au patient	
Rassurer le patient sur l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le patient en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher soigneusement les mains	Préparation au port des gants
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (garrot, aiguilles stériles, seringue ou système sous vide, tubes de prélèvement, antiseptique, compresses, coton sec, sparadrap, boîte de sécurité, étiquettes, bon d'examen)
Ôter les gants après préparation du matériel	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le patient de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer le soin
Installer le bras sur un plan stable	
Mettre le garrot au-dessus du site de ponction	Repérage de la veine
Palper et choisir la veine adaptée	Sécurité et efficacité du prélèvement

Désinfecter le site de ponction avec un antiseptique	Prévention du risque infectieux
Laisser sécher l'antiseptique	Obtention de l'efficacité de la désinfection
Réaliser la ponction veineuse avec technique aseptique	Disposition pour obtenir l'échantillon sanguin
Desserrer le garrot dès que le sang s'écoule	Prévention de la stase veineuse
Retirer l'aiguille et comprimer avec une compresse sèche	Prévention de l'hématome
Poser un pansement propre	Protection du point de ponction
Identifier immédiatement les tubes	Traçabilité et sécurité du prélèvement
Éliminer l'aiguille et le matériel souillé dans la boîte de sécurité	Mesures d'asepsie
Reinstaller le patient	Remise en position convenable pour le confort du malade
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'importance de garder le pansement quelques minutes	Prévention du saignement
Conseiller d'éviter de porter une charge avec le bras ponctionné	Prévention de l'hématome
Informé le patient sur la transmission des résultats	Participation du patient au suivi de son état
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le patient et prendre congé avec respect	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné



FICHE N°25 : PRELEVEMENT DE SELLES

Tâches	Contenus / justifications
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (couché ou semi-assis)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (solution prescrite, perfuseur, cathéter IV, garrot, antiseptique, compresses, sparadrap, plateau, boîte de sécurité, potence, support de prescription)
Oter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Vérifier la prescription médicale	Sécurité du patient et respect de la prescription
Installer le matériel et purger le perfuseur	Élimination de l'air pour éviter une embolie gazeuse
Choisir une veine périphérique adaptée	Disposition pour une perfusion efficace et sécurisée
Poser le garrot au-dessus du site choisi	Favorise la dilatation veineuse
Désinfecter la peau du centre vers la périphérie	Réduction du risque d'infection

----- secner l'antiseptique	Obtention de l'efficacité optimale du produit antiseptique
Introduire le cathéter dans la veine	Mise en place de la voie veineuse périphérique
Retirer le mandrin et desserrer le garrot	Rétablissement de la circulation sanguine
Raccorder le perfuseur au cathéter	Permet l'administration de la solution prescrite
Ouvrir le débit et régler la vitesse d'écoulement	Respect de la prescription médicale
Fixer le cathéter avec un sparadrap	Maintien du dispositif en place
Installer confortablement le membre perfusé	Prévention des déplacements du cathéter
Surveiller le point de ponction et l'écoulement	Dépistage précoce des complications (infiltration, douleur, œdème)
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client l'importance de ne pas plier le bras perfusé	Prévention du déplacement du cathéter
Conseiller de signaler toute douleur ou gonflement	Dépistage précoce des complications
Informé sur la durée prévue de la perfusion	Participation du patient au soin
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné

FICHE N°26 : PRELEVEMENT DES CRACHATS

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade assis ou légèrement penché en avant	Mise en condition favorable pour le soin et facilitation de l'expectoration
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (pot stérile pour recueil, gants, compresses, masque si nécessaire, plateau, support de prescription)
Oter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Demander au patient de tousser profondément	Facilite l'expectoration des crachats
Recueillir le crachat directement dans le pot stérile	Garantit de la qualité de l'échantillon
Fermer correctement le pot après le prélèvement	Prévention de la contamination et des fuites

Identifier le pot avec les informations du patient	Traçabilité et identification du prélèvement
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au patient de ne pas contaminer le pot	Prévention des erreurs et infections
Conseiller de recracher uniquement dans le pot stérile fourni	Qualité de l'échantillon pour l'analyse
Informar sur le suivi ou les examens complémentaires si nécessaire	Participation du patient au suivi médical
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Maintien d'un climat de confiance et de respect

FICHE N°27 : PRELEVEMENT DES URINES

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le patient en position confortable, assis sur les toilettes ou couché selon le cas	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (pot ou flacon stérile pour recueil, gants, compresses, champ si nécessaire, support de prescription, collecteur de déchets)
Ôter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informar le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Nettoyer les organes génitaux externes avec une compresse imbibée d'antiseptique	Réduction du risque de contamination

Demander au patient de recueillir les urines dans le flacon stérile	Assurance de la qualité de l'échantillon
Recueillir le milieu de jet pour un prélèvement propre	Limitation des contaminations de surface
Fermer correctement le flacon après le prélèvement	Prévention de la contamination et des fuites
Identifier le flacon avec les informations du patient	Traçabilité et identification du prélèvement
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au patient l'importance de ne pas toucher l'intérieur du flacon	Prévention de la contamination de l'échantillon
Conseiller d'effectuer le prélèvement à l'heure prescrite	Qualité et fiabilité du prélèvement
Informar sur les indications de suivi ou d'analyses supplémentaires	Participation du patient au suivi médical
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Maintien d'un climat de confiance et de respect

V- SOINS CHIRURGICAUX ET DE CONTACT

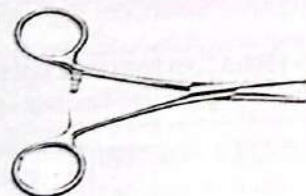
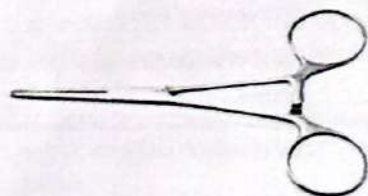
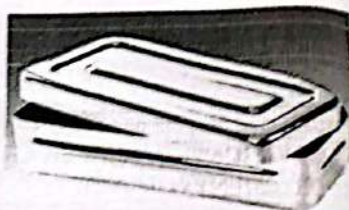
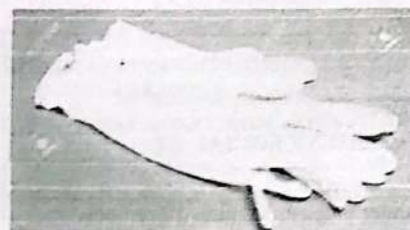
FICHE N°28 : PANSEMENT

TACHES	CONTENUS/JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
1. Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de son diagnostic médical
2. Prévenir le malade du soin	Mise en confiance du client
3. Expliquer le soin au malade	Obtention de l'adhésion du client
II- PREPARATION DU MATERIEL	
1. Se laver les mains	Prise de mesures d'asepsie
2. Prendre un chariot à 3 étages ou à défaut 2 étages	Préparation du chariot pour le matériel
3. Prendre un plateau stérile	Disposition pour garantir l'asepsie
4. Prendre la boîte à pansement et son contenu stérilisés	Disposition pour assurer la sécurité du soin
5. Prendre des gants stériles	Prise de mesures d'asepsie et de protection
6. Placer les produits sur l'étage moyen s'il s'agit d'un chariot à 3 étages ou sur le 2 ^{ème} étage s'il s'agit d'un chariot à 2 étages	Disposition des produits sur l'étage correspondant pour faciliter leurs utilisations
7. Placer le réniforme ou haricot sur l'étage inférieur	
8. Passer les mains à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
9. Prendre la pince à servir	
10. Se servir aseptiquement (d'abord la pince de PEAN, la pince à disséquer, la paire de ciseaux et les compresses nécessaires)	Disposition pour servir le matériel stérile
11. Fermer aseptiquement la boîte à pansement	Disposition pour maintenir la stérilité du matériel
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
1. Fermer portes et fenêtres ou installer un paravent pour respecter la pudeur du malade	Prise de mesures pour le respect de l'intimité du patient

2. Installer confortablement le malade dans son lit ou sur la table de pansement	Disposition pour la réalisation du soin
3. Mettre une alèse si nécessaire	Disposition pour protéger le matelas et la literie
4. Se laver les mains	Prise de mesures d'asepsie
5. Passer les mains à l'alcool ou du gel hydro-alcoolisé	
6. Porter les gants stériles	
7. Enlever le bandage ou sparadrap sans toucher aux compresses qui adhèrent à la plaie	Disposition pour minimiser les saignements et la douleur
8. Faire un tampon avec une compresse en se servant de la pince de KOCHER et de la pince à disséquer	Disposition technique pour la réalisation du tampon
9. Imbiber le tampon d'antiseptique au-dessus du haricot	Mesures d'hygiène et d'asepsie
10. Nettoyer le pourtour de la plaie, avant la plaie elle-même, en allant des bords vers l'extérieur avec l'éther	Respect de la technique de nettoyage de la plaie
11. Changer de tampon autant que possible si nécessaire	Mesures d'hygiène et d'asepsie
12. Dans les plaies très souillées, changer de pinces après le nettoyage	
13. Nettoyer la plaie elle-même de l'intérieur vers l'extérieur	Respect de la technique de nettoyage de la plaie
14. Enlever les agrafes ou les fils de sutures si nécessaire	Ablation des agrafes ou des fils en fonction de l'évolution de la plaie
15. Mettre l'antiseptique prescrit sur la compresse pour couvrir la plaie	Mesures de protection et d'hygiène
16. Mettre une compresse sèche sur la compresse imbibée d'antiseptique	
17. Fixer le pansement avec du sparadrap ou une bande	
18. Vider dans la poubelle appropriée les déchets de soins	Gestion sécurisée des déchets biomédicaux et assimilés
19. Oter les gants	Ablation sécurisée des gants
20. Réinstaller confortablement le malade	Remise en position convenable pour le confort du malade
21. Frictionner les mains avec du gel hydro-alcoolisé	Prise de mesures d'asepsie

22. Noter le soin sur la feuille de température ou de surveillance ou encore dans le registre de soins curatifs	Communication et continuité des soins
23. Laver le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
24. Stériliser le matériel	
25. Ranger le matériel pour une utilisation ultérieure	
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMORTEMENTAL (CCSC)	
Informar le client de ne pas manipuler ou changer le pansement	Prévention d'éventuels infection et/ou complication
Signaler toute anomalie observée avant le prochain rdv	Collaboration soignant/soigné dans la surveillance
Surveiller le client s'il est hospitalisé et fixer le rendez-vous pour le prochain pansement après la CCSC	Suivi et évaluation du soin et du patient

QUELQUES MATERIELS POUR LE PANSEMENT



FICHE N°29 : BANDAGE

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Rassurer le patient de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
1. Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
2. Sécher les mains avec une serviette propre	
3. Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
4. Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
5. Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
6. Prendre un chariot à 2 ou 3 étages ou un plateau propre	Organisation rationnelle et sécurisée du matériel
7. Nettoyer le chariot ou le plateau	Réduction du risque de contamination
8. Installer un paravent ou rideau si chambre commune	Respect de l'intimité et de la dignité du patient
9. Réunir tout le matériel nécessaire avant le soin	Évite les interruptions et assure la continuité du soin
10. Disposer le matériel propre à l'étage supérieur	Respect du circuit propre
11. Disposer le matériel septique à l'étage inférieur	Prévention de la contamination croisée
12. Plateau propre ou stérile	Support du matériel utilisé pendant le soin

13. Bandes propres (5, 10, 15 ou 20 cm)	Adaptation à la région anatomique à bander
14. Compresses propres ou stériles	Protection de la peau ou d'une plaie
15. Coton cardé ou hydrophile	Amortissement, protection et confort
16. Sparadrap	Fixation et maintien du bandage
17. Épingles de sûreté	Fixation sécurisée du bandage
18. Ciseaux	Découpe précise des bandes et du sparadrap
19. Drap propre	Protection du lit et respect de la pudeur
20. Alèze (si nécessaire)	Protection de la literie contre les souillures
21. Poubelle ou sac à déchets	Élimination sécurisée des déchets

III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE

1 Laver les mains et les passer à l'alcool	Renforcement de l'asepsie
Enfiler les gants	
Informé le malade de l'imminence du soin	Préparation psychologique
Installer le malade confortablement	Favorise l'immobilité et le confort
Fermer portes et fenêtres	Respect de l'intimité et prévention des courants d'air
Mettre le paravent si nécessaire	Respect de la pudeur
faire aider si besoin	Sécurité et précision du geste
Maintenir le membre dans la position indiquée	Efficacité du bandage
Tenir correctement la bande	Bonne exécution du geste technique
Commencer par 2 circulaires	Fixation initiale du bandage
Adapter la technique au type de bandage	Efficacité thérapeutique
Terminer par 2 circulaires	Stabilité du bandage
Fixer avec sparadrap ou épingle	Maintien durable et sécurisé

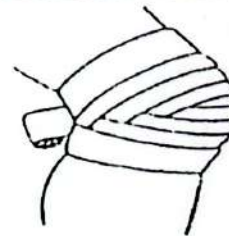
IV- RÉALISATION DU SPICA DU POUCE

Faire 2 circulaires autour du poignet	Fixation de départ
Conduire la bande en diagonale vers le pouce par l'intérieur de la paume.	Maintien du pouce
Redescendre en diagonale vers le poignet	Stabilisation

Effectuer des croisées à la racine du pouce	Renforcement du maintien
Terminer par 2 circulaires au poignet	Fixation finale
Fixer le bandage	Sécurité et durabilité

**V- ENVELOPPEMENT DU GENOU**

Installer le genou en demi-flexion	Favorise un bon ajustement
Faire 2 circulaires autour du genou	Fixation initiale
Réaliser des circulaires progressives	Répartition homogène de la pression
Superposer les tours antérieurs et postérieurs	Maintien optimal
Répéter la technique	Couverture complète
Terminer par 2 circulaires au-dessus du genou	Fixation finale
Fixer le bandage	Stabilité et sécurité

**VI- BANDAGE DU PIED : BAUDENS**

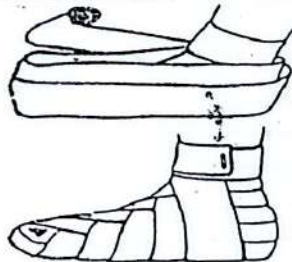
Placer le chef de la bande sur le calcanéum	Point d'ancrage stable
Conduire la bande vers la racine des orteils	Protection du pied
Longer la face dorsale du pied	Répartition de la pression
Passer sous la plante du pied	Maintien solide
Croiser sur le dos du pied	Stabilisation
Répéter la technique	Couverture homogène

Terminer par 2 circulaires au-dessus des malléoles	Fixation finale
Fixer le bandage	Sécurité et efficacité



VII- BANDAGE DU PIED : CHAUSSON

Faire 2 circulaires autour de la cheville	Fixation initiale
Réaliser 3 circulaires autour du talon et des orteils	Protection complète
Recouvrir le 1/3 supérieur et inférieur	Bonne répartition
Conduire la bande sur le tendon d'Achille	Maintien postérieur
Associer un Baudens	Renforcement du bandage
Terminer par 2 circulaires au-dessus des malléoles	Fixation finale



VIII- FIN DU SOIN (POUR TOUS LES BANDAGES)

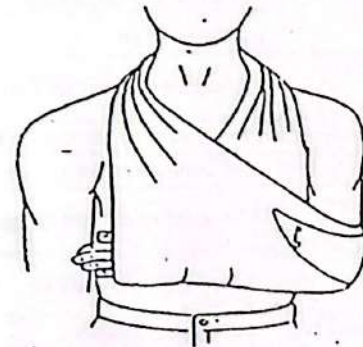
Réinstaller le malade confortablement	Bien-être et sécurité
Couvrir le malade	Protection contre le froid
Consigner le soin	Traçabilité
Retirer le paravent	Rétablissement de l'environnement
Ouvrir portes et fenêtres	Aération
Ranger et nettoyer le matériel	Hygiène du milieu

Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission
Remercier le malade	Humanisation des soins
Prendre congé avec des mots gentils	Relation soignant-soigné respectueuse
IX- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'importance du bandage	Favorise l'adhésion au traitement
Conseiller de garder le bandage propre et sec	Prévention des infections
Sensibiliser à la surveillance des signes anormaux	Détection précoce des complications
Encourager le respect des consignes et contrôles	Continuité et efficacité du soin
Impliquer le patient et la famille	Adoption de bons comportements de santé

FICHE N°30 : RÉALISATION D'UNE ÉCHARPE MOYENNE

FICHE TECHNIQUE DE SOINS : RÉALISATION D'UNE ÉCHARPE MOYENNE	
TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	Diminution de l'anxiété du patient
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
1. Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
2. Assécher les mains	
3. Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
4. Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
5. Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
6. Plateau propre	Facilite l'organisation rationnelle du matériel et limite les contaminations
7. Étoffe carrée de 1 m ²	Permet la réalisation correcte de l'écharpe
8. Electroplaste (bande adhésive)	Assure la fixation et la sécurité
9. Bande Velpeau	Renforce le maintien du membre
10. Épingles de sûreté	Assurent une fixation durable et sécurisée
11. Disposer le matériel sur le chariot	Disposition rationnelle du matériel
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Informé le malade de l'imminence du soin	Préparation psychologique du patient
Fermer les portes et fenêtres	Respect de l'intimité et prévention des courants d'air
Mettre le paravent si chambre commune	Respect de la pudeur du patient
Se faire aider si nécessaire	Sécurité du patient et du soignant

Installer le malade confortablement	Prévention de la douleur et de l'inconfort
Maintenir le membre dans la position indiquée	Facilite la pose correcte de l'écharpe
Mettre l'avant-bras à angle droit sur le bras	Position fonctionnelle du membre
Passer la base du triangle sous le poignet	Soutien et immobilisation du membre
Orienter le sommet vers le coude	Répartition équilibrée du poids
Diriger une pointe vers l'épaule saine	Stabilisation de l'écharpe
Diriger l'autre pointe vers l'épaule malade	Maintien du bras atteint
Nouer les pointes sur la nuque	Fixation correcte de l'écharpe
Fixer le sommet avec une épingle	Sécurisation de l'installation
Réinstaller le malade confortablement	Prévention des douleurs et inconforts
Couvrir le malade	Protection contre les courants d'air
Surveiller les réactions du malade	Détection précoce d'un malaise ou inconfort
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Traçabilité des soins
Prendre congé du malade	Maintien d'une relation soignant-soigné respectueuse
V- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'utilité de l'écharpe	Prévention des douleurs et des complications
Conseiller d'éviter les mouvements brusques	Protection du membre atteint
Encourager le respect des consignes	Amélioration de la guérison
Sensibiliser à signaler toute douleur	Prise en charge rapide



FICHE N°31 : POSE D'UNE GOUTTIERE

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Identifier le malade	Vérification de la présence du patient et de son état général
Se présenter au malade	Instauration d'un climat de confiance soignant-soigné
Expliquer le soin au malade	Obtention de l'adhésion du patient et réduction de l'anxiété
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Chariot à deux étages ou à défaut un étage	Facilite l'organisation rationnelle du matériel et limite les contaminations
Nettoyer le chariot	Maintien de l'environnement de soins propre
Poser la gouttière sur le chariot	Facilite l'organisation rationnelle du matériel
Prévoir du coton ou un pagne pour capitonner la gouttière	Protection du patient
Conduire le chariot au chevet du malade	Évite les déplacements inutiles
Se faire aider si nécessaire	Sécurité du patient et du soignant
Mettre Paravent ou rideau	Assure le respect de l'intimité du patient
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Informé le malade de l'imminence du soin	Préparation psychologique du patient
Fermer les portes et fenêtres	Respect de l'intimité et prévention des courants d'air
Mettre le paravent si chambre commune	Assure le respect de l'intimité du patient
Installer le malade confortablement	Sécurité et confort du patient
Se faire aider si nécessaire	Sécurité du patient et du soignant
Maintenir le membre dans la position indiquée	Sécurité et confort du patient
Poser la gouttière (selon démonstration)	Protection du patient
Ajuster et capitonner la gouttière	Confort du patient

Communiquer avec le malade	Réassurance et coopération du patient
Surveiller les réactions du malade	Détection précoce d'un malaise ou inconfort
Réinstaller le malade confortablement	Prévention des douleurs et inconforts
Couvrir le malade	Protection thermique
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Maintien de la continuité des soins
Prendre congé du malade	Maintien d'une relation soignant-soigné respectueuse
IV- À LA FIN DE LA POSE	
Retirer le paravent	Respect du confort du patient
Ouvrir les portes et fenêtres	Aération et confort du patient
Ranger le matériel	Maintien de l'environnement de soins propre
Faire acheminer le matériel	Respect des règles d'hygiène
V- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'importance de la gouttière	Prévention des complications
Conseiller de signaler toute douleur	Intervention rapide
Sensibiliser à l'immobilisation du membre	Maintien du confort et de la sécurité
Encourager la participation du patient selon ses capacités	Valorisation et autonomie du patient

FICHE N°32 : POSE D'UNE ATTELLE

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	Diminution de l'anxiété du patient
Le rassurer de l'innocuité du geste	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Mise en condition favorable pour le soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesure d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Enfiler des gants propres	Protection du patient et du soignant
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Prendre un chariot de soins ou plateau propre	Facilite l'organisation rationnelle du matériel et limite les contaminations
Prendre une attelle adaptée au membre	Permet une immobilisation correcte du membre atteint.
Prendre du coton ou mousse de protection	Protège la peau et prévient les points de pression.
Se munir de bandes Velpeau	Assurent la fixation stable de l'attelle.
Electroplâsme ou bande adhésive	Renforce la fixation de l'attelle.
Ciseaux	Permettent l'ajustement du matériel.
Mettre le Paravent ou rideau	Assure le respect de l'intimité du patient.
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Installer le patient confortablement	Favorise la coopération et limite la douleur.
Mettre le membre en position fonctionnelle	Prévention des déformations et amélioration du confort.

Observer l'état du membre	Détection de plaies, œdème ou douleurs.
Protéger la peau avec du coton	Prévention des frottements et escarres.
Positionner l'attelle	Assure une immobilisation efficace.
Maintenir l'attelle en place	Garantit la stabilité pendant la fixation.
Fixer l'attelle de bas en haut	Améliore le retour veineux et la stabilité.
Ajuster sans trop serrer	Prévention des troubles circulatoires.
Vérifier la circulation et la sensibilité	Détection précoce d'une compression.
Demander le ressenti du patient	Évaluation du confort et de la douleur.
Réajuster si nécessaire	Amélioration du confort et de la sécurité.
IV- A LA FIN DES SOIN	
Ranger le matériel	Mainien de l'environnement propre.
Évacuer ou nettoyer le matériel	Respect des règles d'hygiène.
Rétiér les gants	Prévention de la contamination.
Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission des infections.
Tracer le soin dans le dossier	Assure la continuité des soins.
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'importance de l'attelle	Favorise la guérison et évite les complications.
Conseiller d'éviter les mouvements	Prévention de l'aggravation de la lésion.
Informar sur les signes d'alerte	Consultation rapide en cas de complication.
Encourager le respect des consignes	Amélioration de l'observance thérapeutique.

FICHE N°33 : UTILISATION DE LA VESSIE DE GLACE

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence du patient et de la prescription médicale
Se présenter au patient	Obtention de la confiance et de l'adhésion
Expliquer le soin au patient	Favorise la compréhension et la collaboration
Rassurer le patient	Diminution de l'anxiété
Vérifier les besoins urgents	Évite l'interruption du soin
Installer le patient en position confortable	Favorise le confort et l'efficacité
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains	Prévention des infections
Mettre des gants si nécessaire	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot ou plateau propre	Organisation du soin
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions
Vessie de glace propre et étanche	Sécurité du patient
Glaçons ou glace pilée	Source de froid thérapeutique
Eau froide (facultatif)	Améliore la diffusion du froid
Housse ou serviette propre	Protection de la peau
Vérifier l'intégrité de la vessie de glace	Prévention des fuites
Remplir la vessie de glace aux 2/3	Évite la surpression
Chasser l'air et fermer hermétiquement	Sécurité d'utilisation
Essuyer la vessie de glace	Évite les écoulements
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Informer le patient du début du soin	Préparation psychologique
Assurer l'intimité si nécessaire	Respect du patient
Tester la tolérance au froid	Prévention des lésions cutanées
Envelopper la vessie de glace dans une housse	Protection de la peau
Appliquer sur la zone indiquée	Action thérapeutique (froid)

TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
Éviter le contact direct avec la peau	Prévention des engelures
Adapter la position du patient	Confort et efficacité
Maintenir pendant 10 à 20 minutes	Durée optimale
Surveiller la peau (rougeur, pâleur)	Détection précoce des complications
Interroger le patient sur ses sensations	Évaluation de la tolérance
Retirer en cas de douleur ou inconfort	Prévention des risques
Retirer après le temps indiqué	Fin du soin
Réinstaller le patient confortablement	Maintien du bien-être
Vider, nettoyer et sécher la vessie de glace	Hygiène du matériel
Ranger le matériel	Organisation
Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'intérêt du froid (anti-douleur, anti-inflammatoire)	Favorise l'adhésion
Conseiller de ne pas appliquer directement sur la peau	Prévention des lésions
Sensibiliser à la durée d'application	Évite les complications
Recommander de signaler toute douleur ou engourdissement	Sécurité du patient
Encourager une utilisation prudente à domicile	Promotion des bonnes pratiques

FICHE N°34 : REALISATION D'UN SONDAGE VESICAL CHEZ L'HOMME

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en décubitus dorsal, jambes légèrement écartées	Mise en condition favorable pour le soin
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (sonde vésicale stérile, poche d'urines, champ stérile, gants stériles, compresses stériles, antiseptique, lubrifiant stérile, seringue d'eau stérile pour ballonnet, plateau, collecteur de déchets, support de prescription)
Ôter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Installer le champ stérile	Maintien de l'asepsie du champ opératoire
Mettre des gants stériles	Prévention des infections urinaires
Nettoyer le gland et le méat urinaire avec un antiseptique	Réduction du risque d'infection
Lubrifier l'extrémité de la sonde	Facilite l'introduction et diminue la douleur

Tenir le pénis perpendiculairement à l'abdomen	Redressement de l'urètre pour faciliter le sondage
Introduire doucement la sonde dans l'urètre	Progression de la sonde vers la vessie
Avancer la sonde jusqu'à l'écoulement des urines	Vérification de la position correcte dans la vessie
Introduire encore quelques centimètres	Assure la bonne mise en place de la sonde
Gonfler le ballonnet avec l'eau stérile prescrite	Maintien de la sonde dans la vessie
Tirer légèrement la sonde jusqu'à résistance	Vérification du bon positionnement du ballonnet
Raccorder la sonde à la poche d'urines	Permet le drainage des urines
Fixer la sonde à la cuisse ou à l'abdomen	Prévention des tractions et traumatismes
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Observer l'aspect et la quantité des urines	Surveillance de l'état urinaire du patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client l'importance de ne pas tirer sur la sonde	Prévention des traumatismes
Conseiller de garder la poche en position déclive	Favorise l'écoulement des urines
Informé de signaler toute douleur ou absence d'urines	Dépistage précoce des complications
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné

FICHE N°35 : REALISATION D'UN SONDAGE VESICAL CHEZ LA FEMME

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui l'anxiété	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	Diminution de du patient
Le rassurer de l'innocuité du geste	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Mise en condition favorable pour le soin
Installer le malade en décubitus dorsal, jambes légèrement écartées et genoux fléchis	
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (sonde vésicale stérile, poche d'urines, champ stérile, gants stériles, compresses stériles, antiseptique, lubrifiant stérile, seringue d'eau stérile pour ballonnet, plateau, collecteur de déchets, support de prescription)
Ôter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informé le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Installer le champ stérile	Maintien de l'asepsie du champ opératoire
Mettre des gants stériles	Prévention des infections urinaires
Nettoyer la vulve et le méat urinaire avec un antiseptique	Réduction du risque d'infection
Lubrifier l'extrémité de la sonde	Facilite l'introduction et diminue la douleur
Séparer délicatement les petites lèvres pour visualiser le méat urinaire	Accessibilité correcte à l'urètre
Introduire doucement la sonde dans l'urètre	Progression de la sonde vers la vessie

Avancer la sonde jusqu'à l'écoulement des urines	Vérification de la position correcte dans la vessie
Introduire encore quelques centimètres	Assure la bonne mise en place de la sonde
Gonfler le ballonnet avec l'eau stérile prescrite	Maintien de la sonde dans la vessie
Tirer légèrement la sonde jusqu'à résistance	Vérification du bon positionnement du ballonnet
Raccorder la sonde à la poche d'urines	Permet le drainage des urines
Fixer la sonde à la cuisse	Prévention des tractions et traumatismes
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Observer l'aspect et la quantité des urines	Surveillance de l'état urinaire du patient
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client l'importance de ne pas tirer sur la sonde	Prévention des traumatismes
Conseiller de garder la poche en position déclive	Favorise l'écoulement des urines
Informé de signaler toute douleur ou absence d'urines	Dépistage précoce des complications
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné

FICHE N°36 : LAVAGE DE VESSIE

TACHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	Diminution de l'anxiété du patient
Le rassurer de l'innocuité du geste	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Mise en condition favorable pour le soin
Installer le malade en décubitus dorsal, jambes légèrement écartées	
II- PREPARATION DU MATERIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Prendre un chariot	Disposition pour assurer la sécurité du soin
Réunir le matériel	Mise à disposition du matériel (sonde vésicale, seringue stérile, solution de lavage prescrite, compresses stériles, gants stériles, champ stérile, collecteur d'urines, plateau, support de prescription, collecteur de déchets)
Ôter les gants	Prévention de la contamination croisée
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Se laver les mains à l'eau et au savon et les passer à l'alcool	Prise de mesures d'asepsie
Informers le client de l'imminence du soin	Disposition pour démarrer les soins
Installer le champ stérile	Maintien de l'asepsie du champ opératoire
Mettre des gants stériles	Prévention des infections urinaires
Vérifier la perméabilité de la sonde vésicale	Disposition pour s'assurer que la sonde est fonctionnelle pour le lavage
Prélever la solution de lavage prescrite	Préparation du produit selon la prescription médicale

Introduire la solution de lavage à l'aide de la seringue	Administration contrôlée dans la vessie
Effectuer un lavage doux par instillation et aspiration	Élimination des débris, caillots ou sécrétions
Recueillir la solution usée dans le collecteur	Suivi de l'élimination et prévention des contaminations
Répéter le lavage si nécessaire selon la prescription	Assurance de l'efficacité du soin
Rincer la sonde avec une petite quantité de solution stérile	Prévention des dépôts et maintien de la perméabilité
Réinstaller le client	Remise en position convenable pour le confort du malade
Lui communiquer le soin réalisé	Information du geste effectué au patient
Observer l'aspect et la quantité des urines	Surveillance pour signaler toute anomalie
Consigner le soin sur la feuille de surveillance	Communication et continuité des soins
Se laver les mains	Prise de mesures d'hygiène et de sécurité pour le soignant
Nettoyer et ranger le matériel	Reconditionnement du matériel pour sa réutilisation
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer au client l'importance de signaler toute douleur, brûlure ou hématurie	Dépistage précoce des complications
Conseiller le respect des horaires de sondage et d'hygiène	Prévention des infections urinaires
Informers sur les soins post-lavage et la surveillance	Participation du patient au suivi de son état
Faire un feed-back au patient	Évaluation du message (vérifier si le patient a compris le message)
Remercier le client et prendre congé de lui avec des mots gentils	Disposition pour maintenir un climat de confiance et de respect dans la relation soignant-soigné

FICHE TECHNIQUE DE SOIN : LAVEMENT EVACUATEUR	
TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	
Le rassurer de l'innocuité du geste	Diminution de l'anxiété du patient
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	Mise en condition favorable pour le soin
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Poire à lavement/bock	Permet l'introduction contrôlée du liquide dans le rectum pour favoriser l'évacuation intestinale.
Tuyau	Assure la conduction du liquide du bock ou de la poire vers la canule sans interruption.
Canule,	Facilite l'introduction non traumatique du liquide dans le rectum.
Lubrifiant	Réduit les frottements, prévient les douleurs et les lésions de la muqueuse rectale.
Alèze	Protège la literie contre les souillures et maintient l'hygiène de l'environnement.
Bassins	Permettent la réception des selles et assurent le confort du patient pendant l'évacuation.
Papier hygiénique,	Assure l'essuyage et le maintien de l'hygiène après l'évacuation.
Serviette	Permet le séchage et la protection du patient après le soin.

Chariot à deux niveaux	Organisation rationnelle du matériel propre et souillé, limitation des contaminations
Alèze imperméable + alèze supplémentaire	Protection du lit et prévention des éclaboussures
Bassin ou récipient de recueil	Collecte de la solution de lavement évacuée
Canule lubrifiée (N° adapté selon l'âge)	Introduction sécurisée et réduction du traumatisme
Lubrifiant (vaseline ou gel hydrosoluble) + compresse stérile	Facilite l'introduction de la canule et maintien de l'asepsie
Eau tiède à 38°C + sel ou savon doux	Solution sécurisée et efficace pour l'évacuation intestinale
Papier hygiénique et serviette propre	Maintien de l'hygiène post-soin et confort du patient
Thermomètre (optionnel)	Vérification de la température de la solution
Bassin pour purger le tube	Élimination de l'air et prévention des douleurs abdominales
Bassin pour nettoyage et flambage du matériel	Désinfection et préparation pour le prochain patient
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Informé le patient de l'imminence du soin	Préparation psychologique et coopération du patient
Faire sortir parents et visiteurs	Respect de l'intimité et concentration sur le soin
Installer le patient confortablement	Facilitation du geste et confort du patient
Se faire aider si nécessaire	Sécurité du patient et du soignant
Placer les alèzes sous le patient	Protection de la literie et prévention des éclaboussures
Se laver les mains ou porter des gants stériles	Respect de l'asepsie et prévention des contaminations
Ajuster le caoutchouc, la canule et le bock	Assure le bon fonctionnement du dispositif
Préparer la solution (½ L eau à 38°C + sel ou savon)	Garantit sécurité et efficacité
Purger le tube	Élimine l'air et évite douleurs ou distensions
Lubrifier la sonde avec une compresse	Facilite l'introduction et réduit le risque de traumatismes
Placer le patient en décubitus latéral ou dorsale adaptée	Confort et relâchement des muscles abdominaux

FICHE N°7 LAVEMENT EVACUATEUR

FICHE TECHNIQUE DE SOIN : LAVEMENT ÉVACUATEUR	
TÂCHES	CONTENUS / JUSTIFICATIONS
I- PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Accueillir le patient si soins ambulatoires, l'identifier si hospitalisation	Vérification de la présence effective du patient et prise de connaissance de la prescription médicale
Se présenter à lui	Obtention de la confiance et de l'adhésion du patient au soin
Expliquer le soin au patient	Diminution de l'anxiété du patient
Le rassurer de l'innocuité du geste	Disposition pour éviter une perturbation du soin
Demander au malade s'il n'a pas de besoin pressant à satisfaire	Mise en condition favorable pour le soin
Installer le malade en position confortable (assis ou couché)	
II- PRÉPARATION DU MATÉRIEL	
Se laver les mains à l'eau et au savon	Prise de mesures d'asepsie
Assécher les mains	
Enfiler les gants propres	Protection du soignant et du patient
Réunir le matériel nécessaire	Évite les interruptions pendant le soin
Poire à lavement/bock	Permet l'introduction contrôlée du liquide dans le rectum pour favoriser l'évacuation intestinale.
Tuyau	Assure la conduction du liquide du bock ou de la poire vers la canule sans interruption.
Canule,	Facilite l'introduction non traumatique du liquide dans le rectum.
Lubrifiant	Réduit les frottements, prévient les douleurs et les lésions de la muqueuse rectale.
Alèze	Protège la literie contre les souillures et maintient l'hygiène de l'environnement.
Bassins	Permettent la réception des selles et assurent le confort du patient pendant l'évacuation.
Papier hygiénique,	Assure l'essuyage et le maintien de l'hygiène après l'évacuation.
Serviette	Permet le séchage et la protection du patient après le soin.

Chariot à deux niveaux	Organisation rationnelle du matériel propre et souillé, limitation des contaminations
Alèze imperméable + alèze supplémentaire	Protection du lit et prévention des éclaboussures
Bassin ou récipient de recueil	Collecte de la solution de lavement évacuée
Canule lubrifiée (N° adapté selon l'âge)	Introduction sécurisée et réduction du traumatisme
Lubrifiant (vaseline ou gel hydrosoluble) + compresse stérile	Facilite l'introduction de la canule et maintien de l'asepsie
Eau tiède à 38°C + sel ou savon doux	Solution sécurisée et efficace pour l'évacuation intestinale
Papier hygiénique et serviette propre	Maintien de l'hygiène post-soin et confort du patient
Thermomètre (optionnel)	Vérification de la température de la solution
Bassin pour purger le tube	Élimination de l'air et prévention des douleurs abdominales
Bassin pour nettoyage et flambage du matériel	Désinfection et préparation pour le prochain patient
III- TECHNIQUE PROPREMENT DITE	
Informar le patient de l'imminence du soin	Préparation psychologique et coopération du patient
Faire sortir parents et visiteurs	Respect de l'intimité et concentration sur le soin
Installer le patient confortablement	Facilitation du geste et confort du patient
Se faire aider si nécessaire	Sécurité du patient et du soignant
Placer les alèzes sous le patient	Protection de la literie et prévention des éclaboussures
Se laver les mains ou porter des gants stériles	Respect de l'asepsie et prévention des contaminations
Ajuster le caoutchouc, la canule et le bock	Assure le bon fonctionnement du dispositif
Préparer la solution (½ L eau à 38°C + sel ou savon)	Garantit sécurité et efficacité
Purger le tube	Élimine l'air et évite douleurs ou distensions
Lubrifier la sonde avec une compresse	Facilite l'introduction et réduit le risque de traumatismes
Placer le patient en décubitus latéral ou dorsale adaptée	Confort et relâchement des muscles abdominaux

Introduire la canule (oblique puis horizontalement)	Respect de l'anatomie et sécurité
Desserrer la pince et demander respiration profonde	Réduction de la douleur et du stress
Administer le lavement à basse pression	Prévention des lésions intestinales
Séparer la canule du tuyau avant que toute l'eau ne soit écoulée	Évite le retour de liquide pollué
Pincer le tube avant de retirer la canule	Limite la contamination et éclaboussures
Ne jamais placer la canule dans le bock	Maintien de l'hygiène du matériel
Remettre le caoutchouc dans l'anneau du bock	Préparation du matériel pour usage futur
Patient garde le lavement 10 minutes	Optimisation de l'efficacité du lavement
Replier l'alèse supplémentaire sur le bassin	Protection contre les éclaboussures
Nettoyer le patient et faire toilette	Maintien de l'hygiène et confort
Réinstaller le patient	Confort et sécurité post-soin
Remercier le patient	Valorisation et maintien d'une bonne relation soignant-soigné
Consigner le soin et l'aspect du liquide	Traçabilité et suivi du patient
Ouvrir portes et fenêtres	Aération et confort du patient
Nettoyer, flamber le bock et bouillir le caoutchouc	Désinfection et sécurité pour le prochain patient
Ranger le matériel	Organisation et préparation pour le prochain soin
Se laver les mains	Rupture de la chaîne de transmission des infections
IV- COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)	
Expliquer l'importance de l'évacuation et de l'hygiène rectale	Prévention des infections et complications
Conseiller de signaler tout inconfort ou complication	Intervention rapide et sécurité du patient
Encourager la participation du patient selon ses capacités	Valorisation et autonomie du patient

FICHE N°38 : BOUILLOTTE

Tâches	Justifications
PREPARATION PSYCHOLOGIQUE	
Saluer le malade : Se présenter par son nom et sa fonction.	Instaure un climat de confiance et d'humanité.
Expliquer le but du soin : Préciser si c'est pour la douleur ou le réconfort.	Réduit l'appréhension et favorise la coopération.
Vérifier le consentement : Demander l'accord explicite du patient.	Respecte l'éthique de soins et l'autonomie de la personne.

II. PREPARATION DU MATERIEL

Tâches	Justifications
Bouillotte et housse : Vérifier l'usure du caoutchouc et la propreté.	Sécurité du patient et hygiène du matériel.
Eau chaude (max 50°C) : Utiliser une eau tempérée, jamais bouillante.	Prévention stricte des brûlures accidentelles.
Bouchon avec joint : S'assurer de la présence du joint en caoutchouc.	Garantit l'herméticité et évite les fuites dans le lit.

III. TECHNIQUE PROPREMENT DITE

Étapes de réalisation	Justifications Professionnelles
Remplissage aux 2/3 : Verser l'eau doucement dans le réservoir.	Permet à la bouillotte de rester souple et de ne pas être trop lourde.
Chasser l'air : Presser le corps de la bouillotte jusqu'au goulot.	Améliore la conduction thermique et évite les bruits de liquide.
Test d'étanchéité : Retourner la bouillotte fermée au-dessus d'un bac.	Contrôle final de sécurité avant la pose.
Pose avec protection : Placer la bouillotte housée sur la zone.	

IV. COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL (CCSC)

Actions CCSC	Justifications Professionnelles
Identification des croyances : Demander au patient s'il a l'habitude d'utiliser le chaud à domicile.	Permet d'ajuster le message éducatif en fonction des pratiques culturelles ou personnelles.
Éducation sur l'usage sécurisé : Expliquer pourquoi on ne met pas d'eau bouillante et pourquoi la housse est obligatoire.	Transmet un savoir-faire au patient pour qu'il reproduise le geste sans risque chez lui.
Engagement du patient : Demander au patient de signaler immédiatement toute sensation de picotement ou de chaleur excessive.	Responsabilise le patient dans la surveillance de sa propre sécurité (auto-vigilance).
Renforcement positif : Féliciter le patient pour sa coopération et sa vigilance.	Encourage l'adoption de comportements sécuritaires lors de futurs épisodes de soins.

JE VOUS REMERCIE